Não Compre Drive

2026

GUIA DA UPA

Decisões rápidas.
Ações certeiras.
Zero dúvida.

Disponiibilizado Gratuitamente

SUMÁRIO

AVALIAÇÃO INICIAL E CONDUTA GERAL

EXAME FÍSICO MASCULINO: 6
EXAME FÍSICO FEMININO: 6
EXAME FÍSICO COMPLEMENTAR 7
REAVALIAÇÃO 7
EXAMES COMPLEMENTARES 7
POLITRAUMA 8

SISTEMA RESPIRATÓRIO

ASMA - EXACERBAÇÃO 11
DPOC DESCOMPENSADA 13
RINOSSINUSITE AGUDA 14
TOSSE SECA 16
RINITE ALÉRGICA 17
PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (PAC) 18
PNEUMONIA HOSPITALAR 20
EPISTAXE 21
IOT – INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (INTUBAÇÃO SEQUENCIAL RÁPIDA) 22

ALTERAÇÕES OCULARES

CONJUNTIVITE 25
CORPO ESTRANHO OCULAR 25
CELULITE PERIORBITÁRIA 26

SISTEMA GASTROINTESTINAL

CONSTIPAÇÃO 29
GASTRITE E DRGE 29

Disponiibilizado Gratuitamente

METEORISMO (GASES) 30
DIARREIA AGUDA 30
DIARREIA INESPECÍFICA/ GASTROENTERITE VIRAL 31
DIARREIA POR C. DIFFICILE 33
DIARREIA POR CYCLOSPORA E ISOSPORA BELI 34
DIARREIA POR NEMATELMINTOS 35
PARASITOSES INTESTINAIS 35

ALTERAÇÕES CIRÚRGICAS

COLECISTITE/COLANGITE 39
HÉRNIA NÃO ENCARCERADA 39
APENDICITE 39
PANCREATITE AGUDA 39
CIRROSE HEPÁTICA/ASCITE 40
HDA (HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA) - ÚLCERA PÉPTICA 40
HDA (HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA)- VARIZES ESOFÁGICAS 41
HDA (HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA) - MELENA 41

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

CRISE HIPERTENSIVA 42
URGÊNCIA HIPERTENSIVA 43
EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA 43
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST (IAM COM SUPRA) 44
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRA DE ST (IAM SEM SUPRA) 47
DOR TORÁCICA E ANGINA 49
ARRITMIAS 51
FIBRILAÇÃO ATRIAL / FLUTTER ATRIAL 54
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) 55
CONGESTÃO PULMONAR / EDEMA AGUDO DE PULMÃO 58

DOENÇAS ENDOCRINOLÓGICAS

DM DESCOMPENSADA 60

Disponiibilizado Gratuitamente

DIABÉTICO + HIPERGLICEMIA (G > 250) 60
HIPOGLICEMIA 61

DOENÇAS INFECCIOSAS

DENGUE 63
CHIKUNGUNYA 65
ZIKA VÍRUS 66
OTITE EXTERNA AGUDA (OEA) 67
OTITE MÉDIA AGUDA (OMA ou AOM) 68
FARINGOAMIGDALITE INESPECÍFICA 68
FARINGOAMIGDALITE ESTREPTOCÓCICA 68
INTERTRIGO - CANDIDÍASE 69

SISTEMA URINÁRIO

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (CISTITE NÃO COMPLICADA) 70
CÓLICA NEFRÉTICA 70
PIELONEFRITE 73
DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS 73
CÁLCIO 73
FÓSFORO 74
MAGNÉSIO 74
POTÁSSIO 74
SÓDIO 75
SEPSE: 76

DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E ALÉRGICAS

ERISIPELA E CELULITE NA EMERGÊNCIA 78
ALERGIA E PRURIDO 79
HERPES ZÓSTER 80
ÚLCERAS DE CAUSAS VARIADAS 81
ESCABIOSE 82
FURÚNCULO 82
IMPETIGO CROSTOSO 82

Disponiibilizado Gratuitamente

MICOSE SUBUNGUEAL E PAQUIONÍQUIA 83
NASOFARINGITE AGUDA – RESFRIADO COMUM 83
ECZEMA DE CONTATO 83
HORDÉOLO VOLUMOSO / BLEFARITE INTENSA 84
TINHA CAPITIS 84
TINHA CORPORIS 85
QUEIMADURAS 85
SUTURA: 86

SISTEMA NERVOSO E PSIQUIÁTRICO

CEFALEIAS PRIMÁRIAS 87
CEFALEIA TENSIONAL 87
CONVULSÃO 87
DEPRESSÃO 88
LABIRINTITE 88
AVC HEMORRÁGICO 89
AVC ISQUÊMICO 90
SOLUÇO + VÔMITOS (SEQUELAS DE AVCI) 91
ESQUIZOFRENIA 91
PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA (DE BELL) 91
ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA 92
CALMANTES FITOTERÁPICOS 95
CATATONIA, ACATISIA, AGITAÇÃO 95
SURTO PSICÓTICO- MANIA - AGRESSIVIDADE 95
COMA ALCOÓLICO 96
CRISE DE ANSIEDADE - PÂNICO 96

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

LOMBALGIA MECÂNICA 97
TORCICOLO ESPASMÓDICO 98
TRAUMA TORÁCICO – ANALGESIA OTIMIZADA 99

Disponiibilizado Gratuitamente

BURSITE 99
GOTA 100
SAÚDE DA MULHER
ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 102
DISMENORREIA 102
SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL: 102
VAGINOSE BACTERIANA 103
CANDIDÍASE 103
TRICOMONÍASE 104
GONORREIA 104
CANCRO MOLE 105
LINFOGRANULOMA VENÉREO 105
SÍFILIS 105
HERPES GENITAL 106
DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA AGUDA (DIP) 106
ABUSO SEXUAL 107
HEMOTRANSFUSÃO
OUTRAS EMERGÊNCIAS
CHOQUE HIPOVOLÊMICO 112
TRANSFUSÃO SANGUÍNEA 112
CHOQUE ANAFILÁTICO 113
INTOXICAÇÃO EXÓGENA 114
ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO 114
RAIVA 114

Disponiibilizado Gratuitamente

AVALIAÇÃO INICIAL E CONDUTA GERAL

EXAME FÍSICO MASCULINO:

PACIENTE REFERE _____.
AP: NEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS OU DEMAIS COMORBIDADES
EF: BEG, HIDRATADO, NORMOCORADO, ANICTÉRICO, ACIANÓTICO, AFEBRIL, EUPNEICO, LÚCIDO E ORIENTADO, NORMOCÁRDICO E NORMOTENSO.
PA: __ MMHG FC: __ BPM TAX: __ °C SATO2: __ % EM AA HGT ___ MG/DL

- ACV: RCR, SEM B3 OU B4, BNF, SEM SA
- AR: MV+ EM AHT, SEM RA
- ABD: SEMIGLOBOSO, FLÁCIDO, RHA+, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL OU PROFUNDA, DB (-), MURPHY (-), GIORDANO (-), SEM VMG OU MP
- NEU: GLASGOW 15, PIFR, FORÇA MUSCULAR GRAU V, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA, NISTAGMO OU ATAXIA
- EXT: AQUECIDAS, SEM EDEMAS, COM PULSOS PERIFÉRICOS CHEIOS E SIMÉTRICOS, TEMPO DE REENCHIMENTO CAPILAR < 2 SEG

EXAME FÍSICO FEMININO:

PACIENTE REFERE _____.
AP: NEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS OU DEMAIS COMORBIDADES
NEGA ATRASO MENSTRUAL, GESTAÇÃO OU AMAMENTAÇÃO
EF: BEG, HIDRATADA, NORMOCORADA, ANICTÉRICA, ACIANÓTICA, AFEBRIL, EUPNEICA, LÚCIDA E ORIENTADA, NORMOCÁRDICA E NORMOTENSA.
PA: __ MMHG; FC:__ BPM ;TAX: __ °C ;SATO2: __ % EM AA;HGT ___ MG/DL

- ACV: RCR, SEM B3 OU B4, BNF, SEM SA
- AR: MV+ EM AHT, SEM RA
- ABD: SEMIGLOBOSO, FLÁCIDO, RHA+, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL OU PROFUNDA, DB (-), MURPHY (-), GIORDANO (-), SEM VMG OU MP
- NEU: GLASGOW 15, PIFR, FORÇA MUSCULAR GRAU V, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA, NISTAGMO OU ATAXIA
- EXT: AQUECIDAS, SEM EDEMAS, COM PULSOS PERIFÉRICOS CHEIOS E SIMÉTRICOS, TEMPO DE REENCHIMENTO CAPILAR < 2 SEG

CONDUTA

- PRESCREVO:

- ALTA COM ORIENTAÇÕES MÉDICAS E SEGUIMENTO AMBULATORIAL EM PSF

Disponiibilizado Gratuitamente

- ORIENTO PACIENTE A RETORNAR EM CASO DE NOVAS QUEIXAS OU INTERCORRÊNCIAS

EXAME FÍSICO COMPLEMENTAR

- CAVIDADE ORAL E OROFARINGE: SEM EVIDÊNCIAS DE HIPEREMIAS, ADENOMEGALIAS, ABAULAMENTOS PATOLÓGICOS, PLACAS OU EXSUDATOS
- PESCOÇO: TRAQUEIA CENTRADA, MUSCULATURA TÓPICA, SEM ALTERAÇÕES CUTÂNEAS À INSPEÇÃO, AUSÊNCIA DE MASSAS OU TUMORAÇÕES À PALPAÇÃO.
- ANOPERÍNEO: PELE E MUCOSA ÍNTEGRAS, TOQUE RETAL COM ESFÍNCTER NORMOTENSO, SEM TUMORAÇÕES, COM FEZES EM AMPOLA RETAL, PASTOSAS, SEM MELENA EM DEDO DE LUVA.
- OTOSCOPIA:
  - **OE:** MEATO ACÚSTICO EXTERNO COM PELE ÍNTEGRA, SEM LESÕES OU OBSTRUÇÕES; MT ÍNTEGRA, TRANSLÚCIDA, SEM ABAULAMENTOS OU NÍVEL HÍDRICO, CONE LUMINOSO VISÍVEL E TÓPICO.
  - **OD:** MEATO ACÚSTICO EXTERNO COM PELE ÍNTEGRA, SEM LESÕES OU OBSTRUÇÕES; MT ÍNTEGRA, TRANSLÚCIDA, SEM ABAULAMENTOS OU NÍVEL HÍDRICO, CONE LUMINOSO VISÍVEL E TÓPICO.

REAVALIAÇÃO

MASCULINO:

PACIENTE EVOLUIU ESTÁVEL, REFERINDO MELHORA SINTOMÁTICA APÓS MEDICAÇÃO, SEM RELATO DE NOVAS QUEIXAS OU INTERCORRÊNCIAS. NO MOMENTO SEGUE EM BEG, GLASGOW 15 E EUPNEICO EM AR AMBIENTE.

FEMININA:
PACIENTE EVOLUIU ESTÁVEL, REFERINDO MELHORA SINTOMÁTICA APÓS MEDICAÇÃO, SEM RELATO DE NOVAS QUEIXAS OU INTERCORRÊNCIAS. NO MOMENTO SEGUE EM BEG, GLASGOW 15 E EUPNEICA EM AR AMBIENTE.

EXAMES COMPLEMENTARES

RX DE TÓRAX: SEM EVIDÊNCIAS DE PNEUMOTÓRAX, CONDENAÇÕES, DP, FRATURAS, DISTOPIAS OU DEMAIS ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS AGUDAS
RX DE ABDOME AGUDO: SEM EVIDÊNCIAS DE PNEUMOPERITÔNEO, DISTENSÃO DE ALÇAS INTESTINAIS, ALÇAS SENTINELAS OU DEMAIS ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS AGUDAS
ECG: SINUSAL, DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE

Disponiibilizado Gratuitamente

HEMOGRAMA SEM SINAIS DE ANEMIA, LEUCÓCITOS E PLAQUETAS NO INTERVALO DA NORMALIDADE
FUNÇÃO RENAL PRESERVADA
TRANSAMINASES SEM ELEVAÇÃO SIGNIFICATIVA
EAS SEM ALTERAÇÕES DIGNAS DE NOTA
MARCADORES DE NECROSE MIOCÁRDICA NO INTERVALO DA NORMALIDADE
AMILASE SEM ELEVAÇÃO SIGNIFICATIVA
PCR SEM ELEVAÇÃO SIGNIFICATIVA
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES SEM ELEVAÇÃO
ELETRÓLITOS NO INTERVALO DA NORMALIDADE

POLITRAUMA

PACIENTE TRAZIDO POR …

>> AVALIAÇÃO PRIMÁRIA:
A – VASOATIVO PRESENTE (VAP), COM CONTROLE CERVICAL (CC) E PROTEÇÃO DE VIA AÉREA (PR).
B – MURMÚRIO VESICULAR PRESENTE BILATERALMENTE, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS. SATO2: __ % EM AR AMBIENTE
C – RITMO CARDÍACO REGULAR COM BULHAS NORMAIS E FREQÜÊNCIA, ABDOME INDOLOR, PELVE ESTÁVEL, SEM FRATURAS DE OSSOS LONGOS. FC: __ BPM; PA: __ MMHG
D – GLASGOW 15, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM DÉFICITS NEUROLÓGICOS.
E – ESCORIAÇÕES.
A – NEGA ALERGIAS / M – NEGA MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO / P – NEGA COMORBIDADES /
L – INGESTA DE LÍQUIDOS E ALIMENTOS HÁ __ HORAS / A – VIA PÚBLICA

>> AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA:

- **CABEÇA E PESCOÇO:** NÃO APRESENTA DEFORMIDADES OU CREPITAÇÕES À PALPAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FACE E CRÂNIO, SEM PRESENÇA DE FERIMENTOS OU CONTUSÕES. AUSÊNCIA DE OTORRAGIA OU EPISTAXE. TRAQUEIA CENTRADA, CARÓTIDAS SEM PRESENÇA DE SOPRO. AUSÊNCIA DE CERVICALGIA À PALPAÇÃO E À MOVIMENTAÇÃO PASSIVA E ATIVA DO PESCOÇO.
- **TÓRAX:** CAIXA TORÁCICA SIMÉTRICA, BOA EXPANSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE PERFURAÇÕES, CONTUSÕES OU ESCORIAÇÕES. AUSCULTA COM MURMÚRIO VESICULAR PRESENTE BILATERALMENTE, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS. BULHAS RÍTMICAS E NORMOFONÉTICAS EM 2T, SEM SOPROS AUDÍVEIS.
- **ABDOME:** PLANO, AUSÊNCIA DE PERFURAÇÕES, CONTUSÕES OU ESCORIAÇÕES. RHA+, NORMOTENSO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, SEM VISCEROMEGALIAS OU MASSAS

Disponiibilizado Gratuitamente

PALPÁVEIS. PELVE ESTÁVEL E INDOLOR À COMPRESSÃO ÂNTERO-POSTERIOR.

- **EXTREMIDADES**: AUSÊNCIA DE CONTUSÕES, HEMATOMAS OU DEFORMIDADES. PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES E CHEIOS. SENSIBILIDADE E MOTRICIDADE PRESENTES, FORÇA MUSCULAR GRAU V, TEMPO DE REENCHIMENTO CAPILAR < 3 SEGUNDOS.

MODELO DE EVOLUÇÃO:

PACIENTE EVOLUIU ESTÁVEL, REFERINDO MELHORA SINTOMÁTICA APÓS MEDICAÇÃO, SEM RELATO DE NOVAS QUEIXAS OU INTERCORRÊNCIAS. NO MOMENTO, GLASGOW 15, EUPNEICO EM AR AMBIENTE.

-**RX DE TÓRAX:** SEM EVIDÊNCIAS DE HEMOTÓRAX OU PNEUMOTÓRAX, FRATURAS ÓSSEAS OU DEMAIS LESÕES TRAUMÁTICAS AGUDAS.
-**RX DE PELVE:** SÍNFISE PÚBICA, ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS, LOMBOSSACRAS E DE QUADRIL CONGRUENTES, SEM EVIDÊNCIAS DE FRATURAS ÓSSEAS OU DEMAIS LESÕES TRAUMÁTICAS AGUDAS.

CONDUTA (CD):

- PRESCREVO
- ALTA COM ORIENTAÇÕES MÉDICAS E SEGUIMENTO AMBULATORIAL EM PSF
- ORIENTO PACIENTE E ACOMPANHANTE SOBRE SINAIS DE ALARME E RETORNO EM CASO DE NOVAS QUEIXAS OU INTERCORRÊNCIAS.

RECEITAS PRONTAS (LEMBRE-SE DE INDIVIDUALIZAR CADA PACIENTE, INVESTIGAR ALERGIA, POR EXEMPLO)

ANALGESIA PADRÃO - Posto ###
Rx USO ORAL
1- IBUPROFENO 300 MG _____ 40 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 6/6H POR 05 DIAS
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H
3- PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 6/6H

ANALGESIA PADRÃO - Posto ###
Rx USO ORAL
1- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00

Disponiibilizado Gratuitamente

2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H
3- PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 6/6H

ANALGESIA PADRÃO - Traumas ###
Rx USO ORAL
1- NIMESULIDA 100 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H
3- PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 6/6H

ANALGESIA POTENTE - Traumas ###
Rx USO ORAL
1- CETOPROFENO 150 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H
3- PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 6/6H

ANALGESIA PADRÃO – DOR ABDOMINAL
Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS VO SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H
2- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG ___ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H
3- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

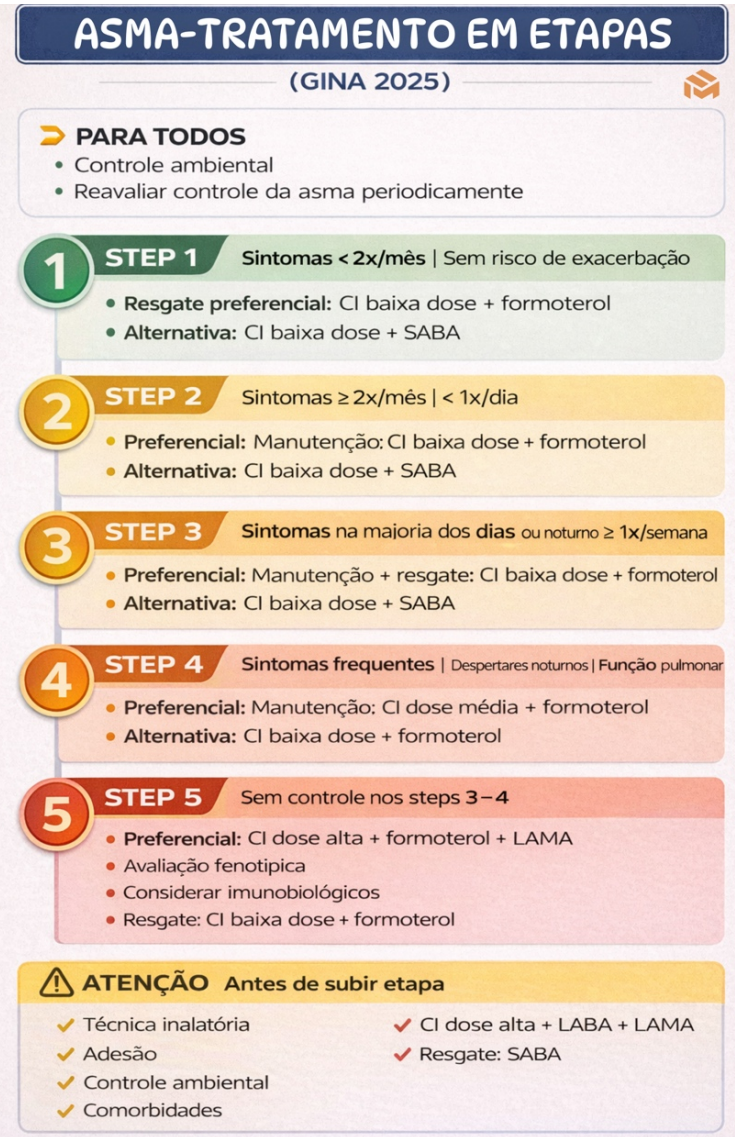
Disponiibilizado Gratuitamente

SISTEMA RESPIRATÓRIO

ASMA - EXACERBAÇÃO

AVALIAÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DE IOT:
- INCAPACIDADE DE FALAR
- MOVIMENTAÇÃO PARADOXAL DO ABDOME (EXAUSTÃO)
- REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA OU AGITAÇÃO
- GASOMETRIA COM ACIDOSE RESPIRATÓRIA
- AUSÊNCIA DE MELHORA COM TRATAMENTO INICIAL

GASOMETRIA NA CRISE ASMÁTICA:
- ***FASE INICIAL:*** ALCALOSE RESPIRATÓRIA
- ***FASE GRAVE (TARDIA):*** ACIDOSE RESPIRATÓRIA



Disponiibilizado Gratuitamente

ASMA-STEP 1

Rx USO INALATÓRIO

1- SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100 MCG _____ 01 FRASCO

INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. PODE REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.
SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA DOSE.
NA AUSÊNCIA DE MELHORA, RETORNAR À EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE

ASMA-STEP 2

Rx USO INALATÓRIO

1- BECLOMETASONA AEROSSOL 50 mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 02 JATOS DE 12/12H, DIARIAMENTE
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00

2- SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100 mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. PODE REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.
SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA DOSE.
NA AUSÊNCIA DE MELHORA, RETORNAR À EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE

ASMA-STEP 3

Rx USO INALATÓRIO

1- BUDESONIDA + FORMOTEROL 100/6mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 CÁPSULA DE 12/12H, DIARIAMENTE
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00

2- SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100 mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. PODE REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.
SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA DOSE.

Disponiibilizado Gratuitamente

NA AUSÊNCIA DE MELHORA, RETORNAR À EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE

ASMA- STEP 4

Rx USO INALATÓRIO

1- BUDESONIDA + FORMOTEROL 200/6mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 CÁPSULA DE 12/12H, DIARIAMENTE

HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00

2- SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100 mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. PODE REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.

SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA DOSE.

NA AUSÊNCIA DE MELHORA, RETORNAR À EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE

Ou

Rx USO INALATÓRIO

1- BUDESONIDA + FORMOTEROL 400/6mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 CÁPSULA DE 12/12H, DIARIAMENTE

HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00

2- SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100 mcg _____ 01 FRASCO

INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. PODE REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.

SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA DOSE.

NA AUSÊNCIA DE MELHORA, RETORNAR À EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE

DPOC DESCOMPENSADA

Rx USO ORAL

1- AMOXICILINA 500 MG _____ 30 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 10 DIAS CONSECUTIVOS

HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00

2- AZITROMICINA 500 MG _____ 07 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 07 DIAS CONSECUTIVOS

3- PREDNISONA 20 MG _____ 05 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 8:00 POR 05 DIAS SEGUIDOS

Disponiibilizado Gratuitamente

4- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H
5- OMEPRAZOL 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ, EM JEJUM, POR 10 DIAS

USO INALATÓRIO
6- SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100 MCG _____ 01 FRASCO
INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. PODE REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.
SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA DOSE.
NA AUSÊNCIA DE MELHORA, RETORNAR À EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE

Exemplos de radiografias que mostram causas de exacerbação e que comumente indicam internação:

Pneumonia

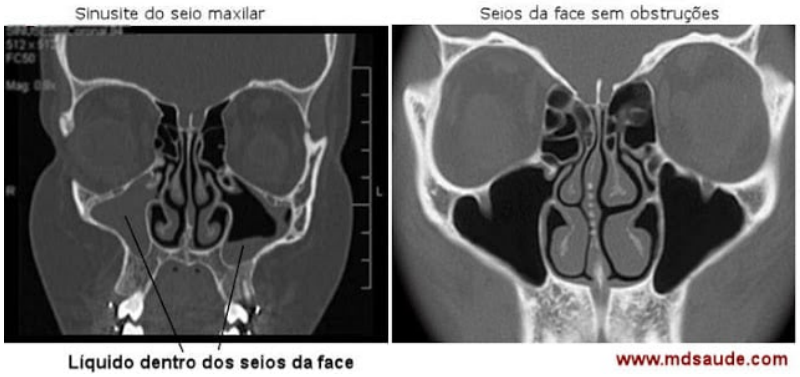
Pneumotórax

Derrame pleural + atelectasia

RINOSSINUSITE AGUDA

A MAIORIA É **VIRAL**.
APENAS 5% EVOLUI PARA BACTERIANA: DESCONFIAR DAS QUE PIORAM APÓS O 5º DIA OU SE MANTÊM POR MAIS DE 10 DIAS.
A **BACTERIANA** COSTUMA PROVOCAR DOR BEM LOCALIZADA E SINAIS SISTÊMICOS.
A **VIRAL** É QUE GERALMENTE SE DISSEMINA DIFUSAMENTE PELAS VIAS AÉREAS SUPERIORES (“COMEÇA COM UMA RINITE, QUE EVOLUI PARA UMA FARINGITE, QUE EVOLUI COM UMA SINUSITE”) E PODE DOER BASTANTE (BASTANTE MESMO!).

Disponiibilizado Gratuitamente



RSVA (VIRAL AGUDA)
Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
USO INTRANASAL
2- FLUTICASONA SPRAY 50mcg/jato _____ 01 FRASCO
APLICAR 1 JATO EM CADA NARINA DE 12/12H POR 15 DIAS
3- SERINGA DE 10 ML _____ 01 UNIDADE
4- SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% _____ 01 FRASCO

Ou
Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
USO INTRANASAL
2- FLUTICASONA SPRAY 50mcg/jato _____ 01 FRASCO
APLICAR 1 JATO EM CADA NARINA DE 12/12H POR 15 DIAS
Em caso de tosse incômoda
- LEVODROPROPIZINA XAROPE 6mg/ml _____ 01 FRASCO
TOMAR 15 ML NO CASO DE TOSSE, PODENDO REPETIR DE 6/6 HORAS
- CODEÍNA 30mg _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO EM CASO DE TOSSE, PODENDO REPETIR DE 8/8 HORAS

RSBA (BACTERIANA AGUDA)
Rx USO ORAL
1- AMOXICILINA 500 MG _____ 42 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 14 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
2- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
USO INTRANASAL
3- FLUTICASONA SPRAY 50mcg/jato _____ 01 FRASCO
APLICAR 1 JATO EM CADA NARINA DE 12/12H POR 15 DIAS
4- MARESIS _____ 01 FRASCO
APLICAR 01 JATO EM CADA NARINA CONFORME NECESSIDADE, PARA

Disponiibilizado Gratuitamente

DESOBSTRUÍ-LA (CERCA DE 5 VEZES AO DIA)
Ou
1- AZITROMICINA 500 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 10 DIAS
2- OMEPRAZOL 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 10 DIAS
3- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
USO INTRANASAL
4- FLUTICASONA SPRAY 50mcg/jato _____ 01 FRASCO
APLICAR 1 JATO EM CADA NARINA DE 12/12H POR 15 DIAS
5- SERINGA DE 10 ML _____ 01 UNIDADE
6- SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% _____ 01 FRASCO

ASPIRAR A SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM A SERINGA E, COM O PACIENTE EM PÉ, INJETAR EM CADA NARINA (NÃO TAPAR A OUTRA), TRÊS VEZES SEGUIDAS, DUAS VEZES AO DIA. É NORMAL ENGOLIR OU A SECREÇÃO SAIR PELO OUTRO LADO
PARA NÃO MACHUCAR O NARIZ, PODE COLOCAR NA PONTA DA SERINGA UMA OLIVA DE ESTETOSCÓPIO (VENDE EM CASAS DE MATERIAL MÉDICO) OU UMA BORRACHA LIMPA DE FONE DE OUVIDO
GUARDAR O SORO NA GELADEIRA E LAVAR O MATERIAL COM ÁGUA E SABÃO

TOSSE SECA

Rx USO ORAL

1- LEVODROPROPIZINA XAROPE 6mg/ml _____ 01 FRASCO

TOMAR 15 ML NO CASO DE TOSSE, PODENDO REPETIR DE 6/6 HORAS

2- CODEÍNA 30mg _____ 30 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO EM CASO DE TOSSE, PODENDO REPETIR DE 8/8 HORAS

GRIPE COMUM

Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 HORAS SE DOR OU FEBRE

2- HISTAMIN 2 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS POR 3 A 5 DIAS

3- AMBROXOL 30 MG/5 ML _____ 01 FRASCO
TOMAR 5 ML DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS
(EXPECTORANTE + ALIVIA IRRITAÇÃO NA GARGANTA)

Disponiibilizado Gratuitamente

USO NASAL
1- SORO FISIOLÓGICO NASAL _____ 01 FRASCO
APLICAR VÁRIAS VEZES AO DIA

RINITE ALÉRGICA

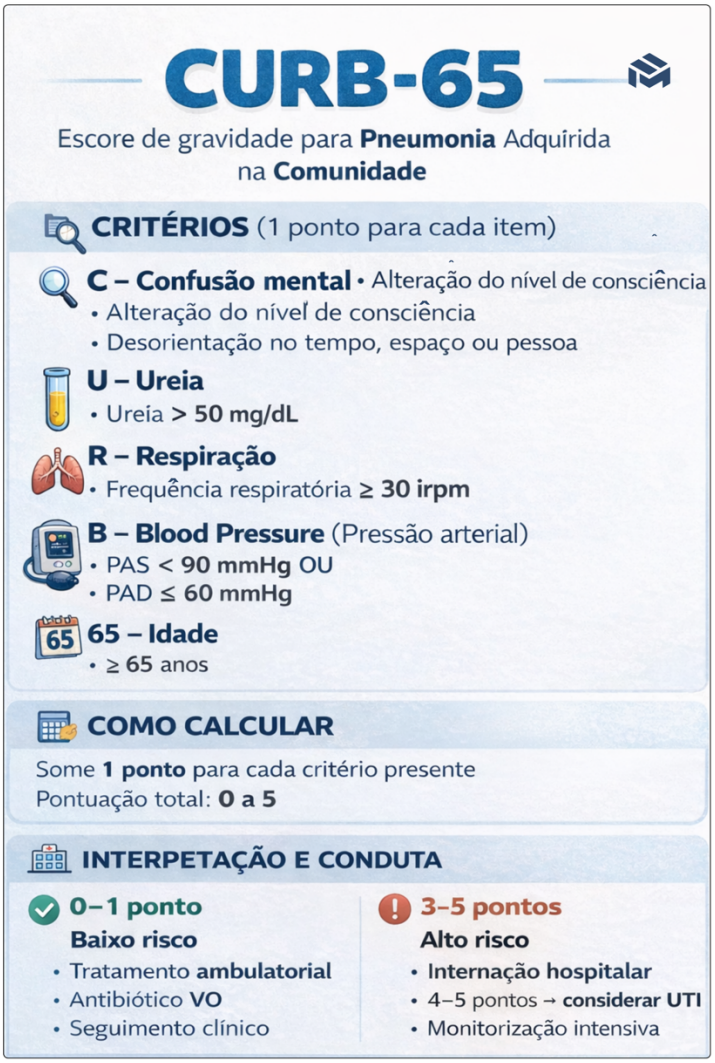
Rx USO ORAL
1- CELESTRAT _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS EM CASO DE ALERGIA
(DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA)

USO NASAL
1- BUSONID NASAL 100 MCG _____ 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 JATOS EM CADA NARINA DE 12/12 HORAS EM CASO DE RINITE
(CORTICOIDE INALATÓRIO)

2- SORINE _____ 01 FRASCO
APLICAR 01 JATO EM CADA NARINA VÁRIAS VEZES AO DIA

Disponiibilizado Gratuitamente

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (PAC)



Etiologia Provável:

- **Agentes Típicos:**Streptococcus pneumoniae//Haemophilus influenzae//Moraxella catarrhalis//Pseudomonas aeruginosa (casos especiais)
- **Agentes Atípicos:**Mycoplasma pneumoniae//Chlamydophila pneumoniae//Legionella spp.

TRATAMENTO AMBULATORIAL (PAC LEVE)

Rx USO ORAL *(escolher um antibiótico)*
1- AMOXICILINA 500 MG _____ **30**

Disponiibilizado Gratuitamente

COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS

Ou

1- AZITROMICINA 500 MG _____ 07 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 7 DIAS

Ou

1- CLARITROMICINA 500 MG _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS

Ou

1- LEVOFLOXACINO 500 MG _____ 07 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 7 DIAS

Ou

1- MOXIFLOXACINO 400 MG _____ 07 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 7 DIAS

ASSOCIAR SINTOMÁTICOS

2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6 HORAS

3- OMEPRAZOL 20 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ EM JEJUM POR 10 DIAS

TRATAMENTO HOSPITALAR (PAC MODERADA A GRAVE)

Antibióticos EV
- CEFTRIAXONA 1G EV 12/12H + CLARITROMICINA 500 MG EV 12/12H

SE RISCO PARA PSEUDOMONAS:
- CEFEPIME 2G 8/8H ou
- PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5G 6/6H ou
- MEROPENEM 1G 8/8H

SE SUSPEITA DE MRSA:
- ASSOCIAR VANCOMICINA

Disponiibilizado Gratuitamente

PNEUMONIA HOSPITALAR

(SINTOMAS A PARTIR DO 3º DIA DE INTERNAÇÃO OU 1 ANO APÓS CIRURGIA – COBERTURA PARA PNEUMOCOCO E PSEUDOMONAS)

Rx USO EV – (ESCOLHER UMA OPÇÃO)

1- CEFEPIME 1G _____ 02 AMP + 100 ML SF 0,9%
INFUNDIR EV DE 8/8 HORAS

Ou

2- CEFTAZIDIMA 1G _____ 01 AMP + 100 ML SF 0,9%
INFUNDIR EV DE 8/8 HORAS

Ou

3- PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G _____ 01 AMP + 100 ML SF 0,9%
INFUNDIR EV DE 6/6 HORAS

Ou

4- LEVOFLOXACINO 500 MG _____ 01 BOLSA PRONTA
INFUNDIR EV 01 VEZ AO DIA

COVID

1) DIPIRONA 500MG——————————————————————1 CAIXA
TOMAR 1 COMPRIMIDO VIA ORAL ATÉ DE 6/6H SE DOR OU FEBRE.

2) ALLEGRA 60 MG ——————————————————————- 1 CX
TOMAR 1 CP, VO, DE 12/12H

3) KOIDE D ——————————————————————— 1 FRASCO
TOMAR 10 ML, VO, DE 8/8H

SE > 1 SEMANA DE SINTOMAS - ASSOCIAR:

4) PREDNISOLONA 20MG_____1 CAIXA

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR DOIS COMPRIMIDOS VIA ORAL, PELA MANHA, DURANTE 5 DIAS

EPISTAXE

SE SANGRAMENTO ATIVO E PERSISTENTE: MEDIDAS LOCAIS IMEDIATAS

01. COMPRESSA DE GAZE COM ADRENALINA 1:1000

EMBEBER GAZE EM *ADRENALINA 1:1000 (1 MG/ML)****. INTRODUZIR NA*** *NARINA SANGRANTE****. REALIZAR*** *COMPRESSÃO DIGITAL NO TERÇO INFERIOR DO NARIZ POR 10 MINUTOS*

SE SANGRAMENTO VOLUMOSO OU RECORRENTE

USO ENDOVENOSO (EV)

02. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG / 5 ML (50 MG/ML)——————————— 03 AMPOLAS (15 ML)
ADMINISTRAR ***EV LENTO****, DOSE ÚNICA.*

SE HIPERTENSÃO ARTERIAL ASSOCIADA (**PAS > 160 MMHG**)

RX USO SUBLINGUAL / ORAL

03. CAPTOPRIL 25 MG – COMPRIMIDO——————————————————— 01 CP
ADMINISTRAR *SUBLINGUAL, DOSE ÚNICA****.***

OU

ANLODIPINO 5 MG – COMPRIMIDO——————————————————— 01 CP
ADMINISTRAR *VO, DOSE ÚNICA****.***

PRESCRIÇÃO PARA CASA

RX USO ORAL

01. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG – COMPRIMIDO
——————————————————————————— 24 COMPRIMIDOS
TOMAR **02 COMPRIMIDOS (500 MG) VO, A CADA 8/8 HORAS**,
POR 3 A 5 DIAS. EM CASO DE EPISTAXES RECORRENTES OU VOLUMOSAS.

Disponiibilizado Gratuitamente

RX USO NASAL

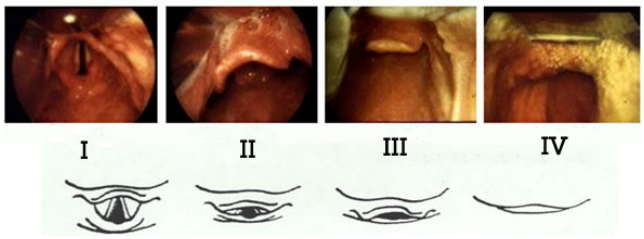
01. SORO FISIOLÓGICO 0,9% (SPRAY NASAL)——————————————— 01 FR
APLICAR *02 A 03 JATOS EM CADA NARINA, 3 A 4 VEZES AO DIA, POR 7 A 10 DIAS.*

(Objetivo: manter mucosa nasal hidratada e prevenir recidiva)

IOT – INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (INTUBAÇÃO SEQUENCIAL RÁPIDA)

A IMAGEM ABAIXO DEMONSTRA OS PREDITORES DE VIA AÉREA DIFICIL.

L	Look	Fácies anormal, trauma facial, barba, ausência de dentes, próteses dentárias, Obesidade, cirurgia prévia do pescoço.
E	Evaluate	Distância inter-incisivos < 3 dedos
M	Mallampati	Distância tireo-mento < 3 dedos
O	Obstruction	Distância da junção do pescoço à proeminência laríngea < 2 dedos
N	Neck Mobility	Mallampati III ou IV



PASSO 1 – PREPARAÇÃO

- MONITORIZAÇÃO COMPLETA
- 02 ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS
- ASPIRADOR DE SECREÇÃO PRONTO

Disponiibilizado Gratuitamente

- BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA CONECTADA AO O_2
- LARINGOSCÓPIO TESTADO (TITULAR + RESERVA; LÂMINAS VARIADAS)
- TUBOS TESTADOS E LUBRIFICADOS (DIVERSOS TAMANHOS)
- COXIM SUBOCCIPITAL
- DROGAS DE EMERGÊNCIA PRONTAS (PCR, ARRITMIA, CHOQUE)
- DROGAS DA IOT IDENTIFICADAS NAS SERINGAS

PASSO 2 – PRÉ-OXIGENAÇÃO

- O_2 A 100% POR 2–5 MINUTOS SEM VENTILAR
- OBS:OBESOS, GESTANTES, CRIANÇAS DESSATURAM MAIS RÁPIDO

PASSO 3 – PRÉ-TRATAMENTO (3 MIN ANTES DA INDUÇÃO)

FENTANIL 500 MCG/10 ML → 3 MCG/KG IV
• 50 KG: 3 ML
• 70 KG: 4,2 ML
• 90 KG: 5,4 ML

LIDOCAÍNA 2% 400 MG/20 ML → 1,5 MG/KG IV
• 50 KG: 3,8 ML
• 70 KG: 5,3 ML
• 90 KG: 6,8 ML

PASSO 4 – INDUÇÃO + PARALISIA

INDUTOR (ESCOLHER 1):

- ***ETOMIDATO 20 MG/10 ML* → 0,3 MG/KG**
  • 50 KG: 7,5 ML
  • 70 KG: 10,5 ML
  • 90 KG: 13,5 ML
- ***QUETAMINA 500 MG/10 ML* → 1,5 MG/KG**
  • 50 KG: 1,5 ML
  • 70 KG: 2,1 ML
  • 90 KG: 2,7 ML
- ***PROPOFOL 200 MG/20 ML* → 1,5 MG/KG**
  • 50 KG: 7,5 ML
  • 70 KG: 10,5 ML
  • 90 KG: 13,5 ML
- ***MIDAZOLAM 50 MG/10 ML* → 0,3 MG/KG**
  • 50 KG: 3 ML
  • 70 KG: 4,2 ML
  • 90 KG: 5,4 ML

BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR (ESCOLHER 1):

- *SUCCINILCOLINA 100 MG* → 1,5 MG/KG
  • 50 KG: 7,5 ML

Disponiibilizado Gratuitamente

  - 70 KG: 10,5 ML
  - 90 KG: 13,5 ML
- *ROCURÔNIO 50 MG/5 ML* → 1 MG/KG
  - 50 KG: 5 ML
  - 70 KG: 7 ML
  - 90 KG: 9 ML

PASSO 5 – POSICIONAMENTO

- AGUARDAR 20 SEGUNDOS APÓS AS DROGAS
- COXIM SUBOCCIPITAL + HIPEREXTENSÃO CERVICAL (EXCETO TRAUMA)

PASSO 6 – PASSAGEM DO TUBO + CONFIRMAÇÃO

- LARINGOSCOPIA DIRETA
- INSERIR TOT + INSUFLAR BALONETE
- CONECTAR À BOLSA-VÁLVULA COM O_2
- AUSCULTAR: EPIGÁSTRIO, HEMITÓRAX DIREITO E ESQUERDO
- CONFIRMAR POSIÇÃO: CAPNOGRAFIA + EXPANSÃO TORÁCICA

Disponiibilizado Gratuitamente

ALTERAÇÕES OCULARES

CONJUNTIVITE

- NOTA: USAR APENAS SE O PACIENTE NÃO TIVER GLAUCOMA.

Rx USO TÓPICO

1- TOBRAMICINA 3mg/mL (COLÍRIO) _____01 FRASCO

PINGAR 1 GOTA EM CADA OLHO, DE 6/6H POR 07 DIAS

HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00

2- SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% _____ 01 FRASCO

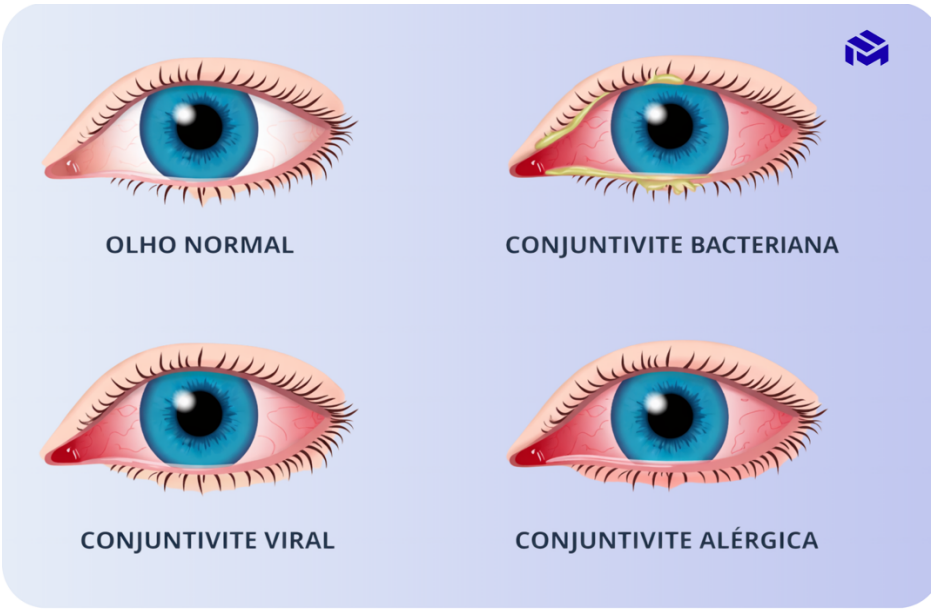
LAVAR OS OLHOS AFETADOS COM SORO GELADO QUATRO VEZES AO DIA.

GUARDAR O SORO NA GELADEIRA.

EVITAR COÇAR OS OLHOS

LAVAR AS MÃOS COM FREQUÊNCIA

NÃO COMPARTILHAR TOALHAS E OBJETOS PESSOAIS



CORPO ESTRANHO OCULAR

- NOTA: USAR APENAS SE O PACIENTE NÃO TIVER GLAUCOMA.

Disponiibilizado Gratuitamente

Rx USO TÓPICO

1- TOBRAMICINA 3mg/mL + DEXAMETASONA 1mg/mL (COLIRIO)_____ 01 FRASCO

PINGAR 1 GOTA EM CADA OLHO, DE 6/6H POR 07 DIAS

HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00

2- SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% _____ 01 FRASCO

LAVAR OS OLHOS AFETADOS COM SORO GELADO QUATRO VEZES AO DIA.

GUARDAR O SORO NA GELADEIRA.

EVITAR COÇAR OS OLHOS

LAVAR AS MÃOS COM FREQUÊNCIA

Opção:

- OFLOXACINO COLÍRIO 0,3% _____ 01 FRASCO

PINGAR UMA GOTA NO OLHO AFETADO DE 6/6H POR 05 DIAS

HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00

CELULITE PERIORBITÁRIA

-CELULITE PERIORBITÁRIA LEVE (TRATAMENTO AMBULATORIAL)
(Paciente em bom estado geral, sem toxemia, com edema palpebral leve a moderado)

USO ENDOVENOSO (EV)

1. DIPIRONA 1 G / 2 ML (500 MG/ML)——————————————— 01 AMPOLA (2 ML)
DILUIR 02 ML EM 18 ML DE SF 0,9%. ADMINISTRAR EV LENTO (10–15 MINUTOS).

ATB INICIAL: USO INTRAMUSCULAR (IM)

2. CEFAZOLINA 1 G – FRASCO-AMPOLA——————————————————
RECONSTITUIR COM 10 ML DE ÁGUA DESTILADA. ADMINISTRAR IM PROFUNDO EM GLÚTEO.

Disponiibilizado Gratuitamente

CELULITE PERIORBITÁRIA MODERADA / GRAVE (OBSERVAÇÃO OU INTERNAÇÃO)

(Paciente com toxemia, febre alta, edema importante, dor intensa ou falha do tratamento ambulatorial)

ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA

USO ENDOVENOSO (EV)

1. CEFAZOLINA 1 G – FRASCO-AMPOLA————————————————
DILUIR EM 50 ML DE SF 0,9%. ADMINISTRAR EV EM 30 MINUTOS, A CADA 8/8 HORAS.

OU

2. OXACILINA 2 G – FRASCO-AMPOLA————————————————————
DILUIR EM 100 ML DE SF 0,9%. ADMINISTRAR EV EM 30 MINUTOS, A CADA 4/4 HORAS.

3. DIPIRONA 1 G / 2 ML (500 MG/ML)———————————— **01 AMPOLA**
DILUIR 02 ML EM 18 ML DE SF 0,9%. ADMINISTRAR EV LENTO, A CADA 6/6 HORAS.

SUSPEITA DE MRSA OU FALHA TERAPÊUTICA

USO ENDOVENOSO (EV)

4. VANCOMICINA 15 MG/KG————————————————————————
DILUIR EM SF 0,9% (CONCENTRAÇÃO FINAL 4–5 MG/ML). ADMINISTRAR EV EM 60 MINUTOS, A CADA 12/12 HORAS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ajustar dose conforme peso e função renal.

Monitorar sinais de nefrotoxicidade.

PRESCRIÇÃO PARA CASA (ALTA)

USO ORAL

1. DIPIRONA 500 MG – COMPRIMIDO———————————— **20 CP**
TOMAR 01 A 02 COMPRIMIDOS VO, A CADA 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE.

Disponiibilizado Gratuitamente

2. IBUPROFENO 600 MG – COMPRIMIDO——————————— **10 CP**
TOMAR 01 COMPRIMIDO VO, A CADA 8/8 HORAS, POR 5 DIAS, APÓS ALIMENTAÇÃO.

3. CEFALEXINA 500 MG – COMPRIMIDO——————————————— **28 CP**
TOMAR 01 COMPRIMIDO VO, A CADA 6/6 HORAS, POR 7 DIAS.

Disponiibilizado Gratuitamente

SISTEMA GASTROINTESTINAL

CONSTIPAÇÃO

Rx USO ORAL

1- BENEFIBER _____ 01 CAIXA

DISSOLVER 01 SACHÊ EM 01 COPO DE ÁGUA OU SUCO E TOMAR AO ALMOÇO POR 28 DIAS

2- SIMETICONA 40 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR (GASES), PODENDO REPETIR DE 6/6H

INGERIR BASTANTE LÍQUIDO (8 A 10 COPOS DE 200ml POR DIA), DIETA RICA EM FIBRAS (FRUTAS, VERDURAS CRUAS, ALIMENTOS INTEGRAIS...), EXERCÍCIO FÍSICO E PROCURAR EVACUAR DIARIAMENTE SEMPRE NO MESMO HORÁRIO

Rx USO ORAL

1- MUVINLAX _____ 01 CAIXA

DISSOLVER 01 SACHÊ EM 01 COPO DE ÁGUA OU SUCO E TOMAR APÓS O CAFÉ DA MANHÃ POR 03 DIAS

2- SIMETICONA 40 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR (GASES), PODENDO REPETIR DE 6/6H

INGERIR BASTANTE LÍQUIDO (8 A 10 COPOS DE 200ml POR DIA), DIETA RICA EM FIBRAS (FRUTAS, VERDURAS CRUAS, ALIMENTOS INTEGRAIS...), EXERCÍCIO FÍSICO E PROCURAR EVACUAR DIARIAMENTE SEMPRE NO MESMO HORÁRIO

GASTRITE E DRGE

Rx USO ORAL

1- OMEPRAZOL 20 MG _____ 128 COMPRIMIDOS

TOMAR 02 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ EM JEJUM, 30 MINUTOS ANTES DO CAFÉ-DA-MANHÃ, POR 08 SEMANAS

2- DOMPERIDONA 10 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO 30 MINUTOS ANTES DO ALMOÇO

3- SIMETICONA 40 MG _____ 01 CAIXA

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR (GASES), PODENDO REPETIR DE 6/6H

ELEVAR A CABECEIRA DA CAMA (15cm): USAR UM APOIO SOB OS PÉS DA CAMA OU TRAVESSEIROS
EVITAR DEITAR-SE NAS DUAS HORAS APÓS AS REFEIÇÕES
DIVIDIR AS REFEIÇÕES EM: Café-da-manhã – Lanche da manhã – Almoço – Lanche da tarde – Jantar – Ceia, E COMER EM MENOR QUANTIDADE EM CADA UMA DELAS.

METEORISMO (GASES)

Rx USO ORAL

1- SIMETICONA 40 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR (GASES), PODENDO REPETIR DE 6/6H

2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

DIARREIA AGUDA

CONSIDERAR SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PRESENÇA DE PELO MENOS 1 DOS FATORES ABAIXO:

• PRESENÇA DE TOXEMIA OU DIARREIA INVASIVA (SANGUE, MUCO OU PUS)
• DESIDRATAÇÃO GRAVE
• IMUNOSSUPRIMIDOS
• IDOSOS

EXAMES A SOLICITAR:

• HEMOGRAMA (HMG)
• UREIA, CREATININA, SÓDIO, POTÁSSIO (U, CR, NA, K)
• EXAME DE FEZES: COPROCULTURA, PESQUISA DE LEUCÓCITOS, LACTOFERRINA, SANGUE OCULTO
• SUSPEITA DE COLITE PSEUDOMEMBRANOSA: PESQUISA DE TOXINA PARA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Disponiibilizado Gratuitamente

PRESCRIÇÃO – ANTIDIARREICO (SE INDICADO)

INDICAÇÃO DE LOPERAMIDA:
- MAIS DE 5 EVACUAÇÕES DIARREICAS POR DIA
- SEM PRESENÇA DE SANGUE NAS FEZES
- SEM SUSPEITA DE E. COLI (EVITAR RISCO DE MEGACÓLON TÓXICO E SHU)

OPÇÃO 1:
RX USO ORAL
1- LOPERAMIDA 2MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, PODENDO REPETIR DE 6/6H

OPÇÃO 2:
RX USO ORAL
1- LOPERAMIDA 2MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS, PODENDO TOMAR 01 A CADA EVACUAÇÃO DIARREICA, ATÉ O MÁXIMO DE 08 COMPRIMIDOS/DIA

DIARREIA INESPECÍFICA/ GASTROENTERITE VIRAL

→ DIARREIA AGUDA SEM SINAIS DE ALARME – DURAÇÃO ESTIMADA DE 7 A 10 DIAS

OPÇÃO 1
RX USO ORAL
1- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

2- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

3- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

4- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

OPÇÃO 2
RX USO ORAL
1- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

3- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

4- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

OPÇÃO 3
RX USO ORAL
1- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

3- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

4- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

5- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

DIARREIA BACTERIANA

(Evacuações com sangue sem fezes - pensar em E. coli enterotoxigênica (não usar ATB, pelo risco de SHU) – geralmente autolimitada, de 3 a 7 dias.

RX USO ORAL
1- CIPROFLOXACINO 500 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

Disponiibilizado Gratuitamente

2- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

5- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

6- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

DIARREIA POR C. DIFFICILE

- (SUSPEITAR EM PACIENTE COM DIARREIA + SINAIS SISTÊMICOS + USO DE ATB RECENTE - ATUAL OU NAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS)

RX USO ORAL
1- METRONIDAZOL 250 MG _____ 60 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 8/8H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 14:00 / 22:00

2- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

5- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

6- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

Disponiibilizado Gratuitamente

DIARREIA POR CYCLOSPORA E ISOSPORA BELI

(COMUM EM PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS)

RX USO ORAL
1- SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400/80 MG _____ 56 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12H POR 14 DIAS

2- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

5- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

6- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

DIARREIA POR PROTOZOÁRIOS

(SUSPEITAR SE DIARREIA > 7 DIAS – CÓLICA, FEBRE, DISENTERIA E TENESMO SUGEREM AMEBÍASE // ESTEATORRÉIA SUGERE GIARDÍASE)

RX USO ORAL
1- SECNIDAZOL 01 G _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

2- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

Disponiibilizado Gratuitamente

5- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

6- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

DIARREIA POR NEMATELMINTOS

(SUSPEITAR SE DIARREIA > 7 DIAS – CÓLICA, FEBRE, DISENTERIA E TENESMO SUGEREM AMEBÍASE // ESTEATORRÉIA SUGERE GIARDÍASE)

RX USO ORAL
1- SECNIDAZOL 01 G _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

2- SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H

5- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

6- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA E GUARDAR NA GELADEIRA.
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO DIARREICA

PARASITOSES INTESTINAIS

EM GERAL:

Rx USO ORAL

1- IVERMECTINA 06 MG _____ 04 COMPRIMIDOS

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR OS 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA, E REPETIR APÓS 07 DIAS

Ou

Rx USO ORAL

1- ALBENDAZOL 400 MG _____ 02 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO EM DOSE ÚNICA E DEPOIS REPETIR APÓS 10 DIAS

Ou

Rx USO ORAL

1- ALBENDAZOL 400 MG _____ 04 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 03 DIAS SEGUIDOS, NO MESMO HORÁRIO, E DEPOIS REPETIR APÓS 10 DIAS

Ou

Rx USO ORAL

1- ALBENDAZOL 400 MG _____ 05 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 05 DIAS SEGUIDOS, NO MESMO HORÁRIO

Ou

Rx USO ORAL

1- SECNIDAZOL 1000 MG _____ 02 COMPRIMIDOS

TOMAR OS 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

Ou

Rx USO ORAL

1- SECNIDAZOL 1000 MG _____ 02 COMPRIMIDOS

TOMAR OS 02 COMPRIMIDOS AO DIA POR 05 DIAS SEGUIDOS, NO MESMO HORÁRIO

Ou

Rx USO ORAL

1- NITAZOXANIDA 500 MG _____ 06 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 03 DIAS SEGUIDOS

HORÁRIO SUGERIDO (12/12H): 08:00 / 20:00

Ou

Disponiibilizado Gratuitamente

Rx USO ORAL

1- PRAZIQUANTEL 500 mg _____ 07 COMPRIMIDOS

TOMAR 04 COMPRIMIDOS E, APÓS 12 HORAS, MAIS 03 COMPRIMIDOS

HORÁRIO SUGERIDO: 04 COMPRIMIDOS ÀS 08:00 E 03 COMPRIMIDOS ÀS 20:00

Ou

Rx USO ORAL

1- PRAZIQUANTEL 500 mg _____ 02 COMPRIMIDOS

TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

CISTICERCOSE

Obs: Praziquantel é CONTRAINDICADO na cisticercose ocular, pois a morte da lava no globo ocular pode provocar intensa reação inflamatória, com perda da visão

Rx USO ORAL

1- PRAZIQUANTEL 500 mg _____ 35 COMPRIMIDOS

TOMAR 02 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ, 01 COMPRIMIDO À TARDE E 02 COMPRIMIDOS À NOITE, POR 07 DIAS SEGUIDOS

2- PREDNISONA 20 mg _____ 05 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 08:00 DA MANHÃ UM DIA ANTES DE INICIAR O PRAZIQUANTEL E MANTER ATÉ QUATRO DIAS DEPOIS (5 DIAS AO TOTAL)

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 02 COMPRIMIDOS VO SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

NEUROCISTICERCOSE

Obs: Praziquantel é CONTRAINDICADO na cisticercose ocular, pois a morte da lava no globo ocular pode provocar intensa reação inflamatória, com perda da visão

Rx USO ORAL

1- PRAZIQUANTEL 500 mg _____ 35 COMPRIMIDOS

TOMAR 02 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ, 01 COMPRIMIDO À TARDE E 02 COMPRIMIDOS À NOITE, POR 07 DIAS SEGUIDOS

Disponiibilizado Gratuitamente

2- PREDNISONA 20 mg _____ 05 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 08:00 DA MANHÃ, OUTRO ÀS 14:00 E OUTRO ÀS 22:00, UM DIA ANTES DE INICIAR O PRAZIQUANTEL E MANTER ATÉ O FINAL DO TRATAMENTO

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 02 COMPRIMIDOS VO SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H

4- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

Disponiibilizado Gratuitamente

ALTERAÇÕES CIRÚRGICAS

COLECISTITE/COLANGITE

1) DIETA ZERO;

2) SF 0,9% - 2000ML, 28 GTS/MIN;

3) RANITIDINA - 2ML + 18ML AD, EV, 12/12H;

4) DIPIRONA 500MG/ML - 01 AMP + 10 ML AD, EV, 6/6H;

5) PLASIL - 2 ML + 8ML AD, EV;

6) CIPROFLOXACINO 200 MG - 01 AMP, EV, 12/12H; OU

7) CEFTRIAXONA 1G - [01 AMP + 10 ML AD, EV, 12/12H] + METRONIDAZOL 500MG - [01 AMP, EV, 8/8H]. 8) INSULINA REGULAR, SC, CONFORME ESQUEMA;

9) GLICOSE 50%-FAZER 4 AMP SE GLICEMIA < 70 MG/DL;

10) SSVV.

HÉRNIA NÃO ENCARCERADA

CETOPROFENO 150 MG + ORIENTAR PROCURAR POSTINHO

APENDICITE

1) DIETA ZERO;

2) SF 0,9%, 500ML, EV;

3) DIPIRONA 500MG/ML _____ 01 AMP, EV + 10 ML AD;

4) CETOPROFENO 100MG _____ 01 AMP + 100 ML SF 0,9%, EV;

5) TRAMAL 50MG/ML _____ 02 AMP + 100 ML SF 0,9%, EV LENTO, 8/8H.

6) METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML _____ 01 AMP, IM

PANCREATITE AGUDA

1) DIETA ZERO

2) HV SF 0,9% 450 ML + 50 ML DE GLICOSE 50%, EV, 4 ETAPAS, 28 GTS/MIN;

3) HV SG 5% 500ML, 28GTS/MIN;

- NACL 10% - 10 ML;

- KCL 10% - 10 ML.

4) RANITIDINA 2ML + 18ML AD, EV, 12/12H;

Disponiibilizado Gratuitamente

5) DIPIRONA 2ML + 8ML AD, EV;

6) BUSCOPAN SIMPLES 2ML + 8ML AD, EV;

7) PLASIL 2ML + 8ML AD, EV;

8) CIPROFLOXACINO 200MG - 01 AMP, EV, 12/12H;

9) METRONIDAZOL 500MG - 01 AMP, EV, 8/8H; 10) CUIDADOS GERAIS

CIRROSE HEPÁTICA/ASCITE

1) DIETA:

- RESTRIÇÃO DE SÓDIO;
- RESTRIÇÃO HÍDRICA SOMENTE SE HIPONATREMIA.

2) FUROSEMIDA 20 MG - 01 AMP, EV, 8/8H.

- DOSE INICIAL: 40-80MG/DIA;
- DOSE MÁXIMA: 160 MG/DIA.
- OBS: AUMENTAR 40 MG A CADA 3-5 DIAS CONFORME NECESSÁRIO.

3) ESPIRONOLACTONA 50 MG - 01 CP, 12/12H;

- DOSE INICIAL: 100-200 MG/DIA;
- DOSE MÁXIMA: 400 MG/DIA.
- OBS: AUMENTAR 100 MG A CADA 3-5 DIAS.

4) TIAMINA 300 MG - 1 CP, VO, 12/12H. OU TIAMINA 100MG/ML - 01 AMP + 250 ML SF 0,9% EV 12/12H.

5) PARACENTESE;

6) ALBUMINA HUMANA 20% 10G/50ML - FAZER X FRASCOS, EV.

- ALBUMINA - 8-10G POR LITRO RETIRADO;
- CADA FRASCO EM 40 MIN;
- INDICAÇÃO: TIRADA > 5L NA PARACENTESE;
- N° de LITROS RETIRADOS X 0,8 = N° de FRASCOS DE ALBUMINA.

7) LACTULONA 667 MG/ML - 20 ML, VO, 8/8H.

HDA (HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA) - ÚLCERA PÉPTICA

1) DIETA ZERO;

2) SNG + LAVAGEM;

3) HIDRATAÇÃO VENOSA (EXPANSÃO VOLÊMICA);

4) ATAQUE: OMEPRAZOL 80 MG + AD, EV, AGORA;

Disponiibilizado Gratuitamente

5) MANUTENÇÃO: OMEPRAZOL 40MG + AD, EV, 12/12H; 6) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ATÉ 12H;

7) TRANSAMIN - 01 AMP, EV;

8) VIT K - 01 AMP, IM.

HDA (HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA)- VARIZES ESOFÁGICAS

1) DIETA ZERO;

2) SNG + LAVAGEM;

3) HIDRATAÇÃO VENOSA (EXPANSÃO VOLÊMICA);

4) OCTREOTIDE 0,5 MG/ML: 01 AMP (1 ML) + SF 0,9% 100ML, EV, EM BIC 10 ML/H POR 3 DIAS;

OU

5) OCTREOTIDE 0,1 MG/ML: 05 AMP (5 ML) + SF 0,9% 100ML, EV, EM BIC 10 ML/H POR 3 DIAS;

- INICIADO ANTES DA ENDOSCOPIA E MANTIDO 3-5 DIAS APÓS. ➔TIAMINA 100MG - 03 AMP + 100 ML DE SF 0,9%, EV, 12/12H, POR 3 DIAS;

6) CEFTRIAXONA 1G, EV, 12/12H, POR 07 DIAS; ➔PROPRANOLOL 20MG - 1 CP DE 12/12H; 7)ENDOSCOPIA DIGESTIVA (LIGADURA ELÁSTICA);

HDA (HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA) - MELENA

1) DIETA ZERO;

2) SF 0,9% - 2000ML, 28 GTS/MIN;

3) PLASIL - 2ML + 8 ML AD, EV;

4) DIPIRONA - 2ML + 8ML AD, EV;

5) RANITIDINA - 2ML + 18 ML AD EV 12/12H;

6) DIMETICONA - 40 GTS, 8/8H, VO, SE DISTENSÃO ABDOMINAL;

7) CAPTOPRIL 25MG, VO, SE PA > 160 X 110;

- SOLICITAR HEMOGRAMA / CONCENTRADO DE HEMÁCIAS - FAZER 2 UI, EV, SN; CUIDADOS GERAIS;
- SNG;
- DESCARTAR CAUSAS ANORRETAIS;
- PARECER PARA ENDOSCOPIA.

Disponiibilizado Gratuitamente

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

CRISE HIPERTENSIVA

ANAMNESE
• É HIPERTENSO? USA MEDICAÇÕES PARA HAS? FAZ USO REGULAR?
• BUSCAR LESÃO DE ÓRGÃO ALVO: "O SENHOR ESTÁ SENTINDO ALGUMA COISA?"

- DOR TORÁCICA, DISPNEIA?

• EM APERTO, NO PRECÓRDIO, DESENCADEADA POR ESFORÇO, IRRADIA PARA MMSS → PENSAR EM IAM
• DOR MUITO FORTE, IRRADIANDO PARA O DORSO → PENSAR EM DISSECÇÃO AÓRTICA
• DISPNEIA VENTILATÓRIO-DEPENDENTE → PENSAR EM TEP

- SINAIS NEUROLÓGICOS FOCAIS?
• FRAQUEZA, FALA ARRASTADA, ALTERAÇÃO VISUAL, DORMÊNCIA, RNC → AVC OU ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA
- SUSPENSÃO DE ÁLCOOL → DELIRIUM TREMENS + CRISE HIPERTENSIVA
- USO DE ANTIPSICÓTICOS → SÍNDROME NEUROLÉPTICA MALIGNA
- USO DE ANTIDEPRESSIVOS → SÍNDROME SEROTONINÉRGICA
- USO DE DROGAS: COCAÍNA, ANFETAMINAS, MACONHA
• PASSANDO POR ESTRESSE EMOCIONAL INTENSO? → PSEUDOCRISE HIPERTENSIVA / CRISE DE ANSIEDADE

EXAME FÍSICO
• CONFIRMAR PRESSÃO ARTERIAL COM EQUIPAMENTO ADEQUADO
• EXAME CARDIOVASCULAR:
- SOPROS (DISSECÇÃO AÓRTICA)
- PULSOS ASSIMÉTRICOS (DISSECÇÃO)
- TURGÊNCIA JUGULAR OU EDEMA DE MMII (ICC)
• EXAME RESPIRATÓRIO:
- MV REDUZIDO (TEP)
- ESTERTORES CREPITANTES (CONGESTÃO PULMONAR = ICC)
• EXAME ABDOMINAL:
- SOPRO ABDOMINAL (HAS RENOVASCULAR OU DISSECÇÃO)
• EXAME NEUROLÓGICO:
- DÉFICIT FOCAL, NÍVEL DE CONSCIÊNCIA
• EXAME OCULAR:
- FUNDOSCOPIA (EX: HEMORRAGIAS, EXSUDATOS, PAPILEDEMA)

Disponiibilizado Gratuitamente

EXAMES COMPLEMENTARES
• RX DE TÓRAX → INVESTIGAR ICC, DISSECÇÃO, TEP
• ECG E ENZIMAS CARDÍACAS (CKMB, TROPONINA) → INVESTIGAR IAM
• TC/RM DE CRÂNIO → AVC OU SINTOMAS NEUROLÓGICOS
• BIOQUÍMICA SÉRICA (CREATININA, SÓDIO, POTÁSSIO, ÁCIDO ÚRICO, EAS COM MICROALBUMINÚRIA) → INVESTIGAR HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA

URGÊNCIA HIPERTENSIVA

(PAS ≥ 180 / PAD ≥ 120)

RX USO ORAL
1- CAPTOPRIL 25 MG _____ 01 COMPRIMIDO, VO, AGORA
OU
1- ANLODIPINO 5 MG _____ 01 COMPRIMIDO, VO, AGORA

2- FUROSEMIDA 40 MG _____ 01 COMPRIMIDO, VO, AGORA
(UTILIZAR SE PACIENTE ESTIVER HIPERVOLÊMICO OU COM EDEMA)

MANEJO:
• AFERIR PA APÓS 30 A 40 MINUTOS
• OBJETIVO: REDUZIR PA PARA CERCA DE 160X100 MMHG EM 24 A 48 HORAS
• OBSERVAR PACIENTE ATÉ ESTABILIZAÇÃO
• MEDICAÇÕES POSSÍVEIS POR VIA ORAL:
- CAPTOPRIL
- CLONIDINA
- NIFEDIPINO
- HIDRALAZINA

EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

(PAS ≥ 180 / PAD ≥ 120) + LESÃO DE ÓRGÃO ALVO (LOA)

• INTERNAR EM UTI _____ REGULAR
• INICIAR NITROPRUSSIATO DE SÓDIO (NIPRIDE) _____
DOSE INICIAL: 0,3 MCG/KG/MIN
DOSE ALVO: 5 MCG/KG/MIN
DOSE MÁXIMA: 10 MCG/KG/MIN

MANEJO:
• TRATAR A LOA ESPECÍFICA ASSOCIADA

Disponiibilizado Gratuitamente

• OBJETIVO: REDUZIR PA EM 20-25% NAS PRIMEIRAS 3 HORAS
• ALVO COMUM: PA ≈ 160 X 110 MMHG EM 6 A 12 HORAS

EXCEÇÕES:

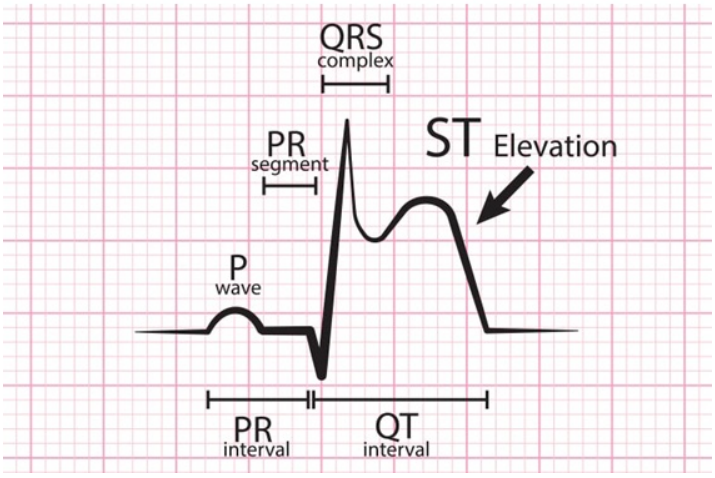
- **AVCH (HEMORRÁGICO):** REDUZIR PA, SE > 180 X 105 MMHG (PAM > 130)

- **AVCI (ISQUÊMICO):**
  • REDUZIR PA, SE > 220 X 120 MMHG
  • OU > 185 X 110 MMHG SE FOR CANDIDATO A TROMBÓLISE
  • IMPORTANTE MANTER PPC ADEQUADA (PPC = PAM – PIC)

- **DISSECÇÃO AÓRTICA:**
  • REDUZIR PAS PARA < 120 MMHG
  • REDUZIR FC PARA < 60 BPM

MEDICAÇÕES EV UTILIZADAS:
• NIPRIDE (NITROPRUSSIATO DE SÓDIO)
• NITROGLICERINA
• METOPROLOL
• ESMOLOL
• HIDRALAZINA

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRA DE ST (IAM COM SUPRA)



1. MONITORIZAÇÃO INICIAL

Disponiibilizado Gratuitamente

- SINAIS VITAIS (SSVV)
- SUPORTE DE OXIGÊNIO (MÁSCARA 3L/MIN)
- ACESSO VENOSO CALIBROSO
- MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA + DESFIBRILADOR À BEIRA-LEITO
- AVALIAÇÃO ABC / MOVED
- ECG 12 DERIVAÇÕES (REALIZAR EM ATÉ 10 MINUTOS)

INTERPRETAÇÃO DO ECG POR TERRITÓRIO:

- **D2, D3, AVF** → PAREDE INFERIOR → A. CORONÁRIA DIREITA
- **D1, AVL** → PAREDE LATERAL → A. CIRCUNFLEXA
  V1 A V6 → PAREDE ANTERIOR → A. DESCENDENTE ANTERIOR

EXAMES: TROPONINA E CK-MB

2. ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA
(INICIAR ANTES DO ECG, SE SUSPEITA CLÍNICA)

RX USO ORAL
1- AAS 100 MG _____ 03 COMPRIMIDOS VO, DOSE DE ATAQUE
2- CLOPIDOGREL 75 MG _____ 04 COMPRIMIDOS VO, DOSE DE ATAQUE

→ **SE IDADE > 75 ANOS** E CANDIDATO A **TROMBÓLISE** → 01 COMPRIMIDO VO

3. ANTICOAGULAÇÃO (ESCOLHER UMA OPÇÃO)

OPÇÃO 1 – ENOXAPARINA (HBPM):

- *ATAQUE*: 30 MG IV EM BOLUS
- *MANUTENÇÃO*: 1 MG/KG SC 12/12H
  SE IDADE > 75 ANOS → 0,75 MG/KG SC 12/12H

OPÇÃO 2 – HEPARINA NÃO FRACIONADA (HNF):

- *ATAQUE*: 60 UI/KG EM BOLUS IV
- *MANUTENÇÃO*: 12 UI/KG/H, EM BIC IV
- *OBJETIVO*: MANTER TTPA ENTRE 1,5 A 2,5 VEZES O VALOR NORMAL

4. ANTIANGINOSOS
OPÇÃO 1 – NITRATO SUBLINGUAL:
ISORDIL 5 MG _____ VO, SL, REPETIR ATÉ 03 VEZES A CADA 5 MINUTOS
CONTRAINDICADO SE: HIPOTENSÃO, USO DE SILDENAFIL, IAM DE VD

Disponiibilizado Gratuitamente

OPÇÃO 2 – MORFINA:
MORFINA 10 MG/ML _____ DILUIR 01 ML + 09 ML DE AD
ADMINISTRAR 3 A 5 ML IV LENTAMENTE (SE DOR REFRACTÁRIA AO NITRATO)

OPÇÃO 3 – NITRATO EV (TRIDIL):
TRIDIL 50 MG/10 ML _____ DILUIR EM 240 ML SG 5%
INICIAR BIC: 5 ML/H
INDICAÇÃO: CRISE HIPERTENSIVA NO CONTEXTO DO IAM

5. REPERFUSÃO CORONARIANA
OPÇÃO 1 – ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA (CAT):

- *TEMPO PORTA-BALÃO:* ATÉ 90 MINUTOS
- *TEMPO TOTAL (PRÉ-HOSPITALAR):* ATÉ 120 MINUTOS

OPÇÃO 2 – TROMBÓLISE (SE CAT INDISPONÍVEL):

- *FIBRINOLÍTICOS*: TENECTEPLASE OU ALTEPLASE
- *TEMPO PORTA-AGULHA:* ATÉ 30 MINUTOS
- CONTRAINDICADO SE TEMPO DE SINTOMAS > 12 HORAS

6. BETABLOQUEADORES (BB)

- INICIAR SE SEM CONTRAINDICAÇÕES (EX: BRADICARDIA, CHOQUE, ICC GRAVE)
- EXEMPLOS:
  METOPROLOL 25 A 50 MG VO, 2 A 4X/DIA
  ATENOLOL 50 A 100 MG VO, 1X/DIA

7. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (IECA)

- INICIAR NAS PRIMEIRAS 24 HORAS, SE POSSÍVEL
- PRINCIPAIS INDICAÇÕES:
  - DISFUNÇÃO VENTRICULAR
  - HIPERTENSÃO
  - DIABETES MELLITUS

8. ESTATINAS (ALTA POTÊNCIA)

- INICIAR AINDA DURANTE INTERNAÇÃO
  1- ATORVASTATINA 80 MG _____ 01 COMPRIMIDO VO,1X/DIA

Disponiibilizado Gratuitamente

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM SUPRA DE ST (IAM SEM SUPRA)

DUPLA ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA

01. AAS 100 mg – comprimido
Ataque: ***300 mg VO (3 comprimidos), mastigar e engolir, agora***
Manutenção: ***100 mg VO, 1x/dia***

02. CLOPIDOGREL 75 mg – comprimido
Ataque: ***300 mg VO (4 comprimidos), agora***
*(Usar **600 mg VO** se cateterismo previsto em < 24h)*
Manutenção: ***75 mg VO, 1x/dia***

OU

TICAGRELOR 90 mg – comprimido
Ataque: ***180 mg VO (2 comprimidos), agora***
Manutenção: ***90 mg VO, 12/12h***

Inibidor de P2Y12 iniciar apenas se **cateterismo NÃO previsto em < 24h**.

ANTICOAGULAÇÃO

03. ENOXAPARINA 60 mg / 0,6 mL (100 mg/mL) – seringa pronta
*Administrar **1 mg/kg SC, de 12/12h***
Dose máxima: **100 mg por dose**

Idade > 75 anos: **0,75 mg/kg SC 12/12h**

ClCr < 30 mL/min: **1 mg/kg SC 24/24h**

CONTROLE DA DOR / ISQUEMIA

04. DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 mg – comprimido
*Administrar **01 comprimido SL, agora***
Repetir **a cada 5 minutos**, se dor persistente
Dose máxima: **03 comprimidos (15 mg)**

Disponiibilizado Gratuitamente

05. NITROGLICERINA 25 mg / 5 mL (Tridil®)
*Diluir **10 mL + 240 mL de SG 5%** em bomba de infusão*
*Iniciar **3 mL/h EV**, titular conforme dor e pressão arterial*

BETABLOQUEADOR

06. METOPROLOL 25 mg – comprimido
*Administrar **01 comprimido VO, 1x/dia***
(Se FC > 60 bpm, PA estável e sem contraindicações)

ESTATINA (ALTA POTÊNCIA)

07. ATORVASTATINA 80 mg – comprimido
*Administrar **01 comprimido VO, agora**,*
manter **80 mg VO, 1x/dia**

IECA

08. ENALAPRIL 5–10 mg – comprimido
*Administrar **01 comprimido VO, de 12/12h***
(Indicado se HAS, DM ou disfunção ventricular)

PROTEÇÃO GÁSTRICA

09. PANTOPRAZOL 40 mg – comprimido
*Administrar **01 comprimido VO, 1x/dia***

SE NECESSÁRIO

10. MORFINA 10 mg/mL
*Diluir **1 mL + 9 mL de SF 0,9%***
Administrar **2–4 mL EV lento**, se dor refratária a nitratos

11. ONDANSETRONA 4 mg / 2 mL
*Diluir **2 mL + 8 mL de SF 0,9%***
Administrar **EV lento**, se náuseas ou vômitos

Disponiibilizado Gratuitamente

12. *Cateter nasal* ***2–3 L/min****, se* ***$SatO_2$ < 90%***

DOR TORÁCICA E ANGINA

CLASSIFICAÇÃO::

ANGINA TÍPICA (DEFINITIVA):

- DOR RETROESTERNAL
- DESENCADEADA POR ESFORÇO OU EMOÇÃO
- MELHORA COM REPOUSO OU USO DE NITRATO

ANGINA ATÍPICA:

- APENAS 02 DOS CRITÉRIOS ACIMA

DOR NÃO CARDÍACA:

- NENHUM DOS CRITÉRIOS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA ANGINA – CCS

- *CLASSE I:* SINTOMAS COM ESFORÇO INTENSO
- *CLASSE II:* > 2 QUARTEIRÕES OU > 1 LANCE DE ESCADA
- *CLASSE III:* 1 QUARTEIRÃO OU 1 LANCE DE ESCADA
- *CLASSE IV:* EM REPOUSO OU MÍNIMO ESFORÇO

ANGINA ESTÁVEL – CONDUTA INICIAL

ANTIAGREGANTE:

RX ORAL
1- AAS 100 MG _____ 01 CP, VO, 1X/DIA

SE CONTRAINDICAÇÃO:
CLOPIDOGREL 75 MG _____ 01 CP, VO, 1X/DIA

ANTI-HIPERTENSIVOS (ESCOLHER CONFORME PERFIL DO PACIENTE):

- ENALAPRIL _____ INICIAR COM 5 MG VO 2X/DIA
- ANLODIPINO _____ 5 A 10 MG VO 1X/DIA

Disponiibilizado Gratuitamente

- HIDROCLOROTIAZIDA _____ 25 MG VO 1X/DIA

DISLIPIDEMIA:

- SINVASTATINA 20-40 MG _____ VO, À NOITE
- OU ATORVASTATINA 10-20 MG _____ VO, 1X/DIA

ANTIANGINOSOS:
1ª LINHA – BETABLOQUEADORES (PREFERENCIAL EM AE):

RX ORAL

1) METOPROLOL SUCCINATO _____ 50 A 200 MG VO, 1X/DIA

2) BISOPROLOL _____ 5 A 20 MG VO, 1X/DIA

3) CARVEDILOL _____ 12,5 A 50 MG VO, 2X/DIA

1ª LINHA PARA VASOESPASMO (ANGINA DE PRINZMETAL): BCC

RX ORAL

1) ANLODIPINO _____ 2,5 A 10 MG VO, 1X/DIA

2) VERAPAMIL _____ 120 A 360 MG VO, 1X/DIA

3) DILTIAZEM _____ 80 A 240 MG VO, 1X/DIA

NITRATOS DE AÇÃO CURTA (PRN):

- SUSTRATE® 10 MG SL
- ISORDIL® 5 MG SL
- MONOCORDIL® 5 MG SL

OUTRAS OPÇÕES (ADJUVANTES):

- TRIMETAZIDINA 35 MG _____ 01 CP VO, 12/12H
- IVABRADINA 5 MG _____ 01 CP VO, 12/12H (MÁX 7,5 MG 12/12H)

ANGINA INSTÁVEL – TRATAR COMO SÍNDROME CORONARIANA AGUDA (SCA/IAMSSST) SE:

- DOR EM REPOUSO > 20 MINUTOS

Disponiibilizado Gratuitamente

- DOR EM CRESCENDO (MAIOR FREQUÊNCIA, INTENSIDADE OU DURAÇÃO)
- ANGINA RECENTE CLASSE CCS III OU IV

ARRITMIAS

BRADIARRITMIAS

CONDUTA INICIAL
- AVALIAR FC < 50 BPM + SINTOMAS (HIPOTENSÃO, CHOQUE, ALTERAÇÃO MENTAL, DOR TORÁCICA ISQUÊMICA, IC)
- MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA + ECG + ACESSO VENOSO + OXIGÊNIO SE HIPOXEMIA

TRATAMENTO

1. **ATROPINA** 0,5 MG IV BÔLUS A CADA 3-5 MIN (DOSE MÁXIMA 3 MG)

Disponiibilizado Gratuitamente

2. ***SE REFRAÇÃO:***
   - **DOPAMINA**: 5 AMP (50 MG/10 ML) + 200 ML SG5%
     INFUSÃO: 2 A 10 MCG/KG/MIN (EX: 70 KG → 8,4 A 42 ML/H)
   - **ADRENALINA**: 6 AMP (1 MG/ML) + 94 ML SF0,9%
     INFUSÃO: 2 A 10 ML/H (2 A 10 MCG/MIN)

3. MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO
   FC ALVO: 70-80 BPM
   AJUSTAR CORRENTE ATÉ CAPTURA ELÉTRICA E MECÂNICA

ANALGESIA E SEDAÇÃO (PRÉ-MARCA-PASSO):

- FENTANIL 1,5 MCG/KG IV
- MIDAZOLAM 0,1–0,2 MG/KG IV (SE NORMOTENSO)
- ETOMIDATO 0,1–0,2 MG/KG IV (SE HIPOTENSO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- BAV MOBITZ II, 2:1, BAV AVANÇADO OU BAVT → IR DIRETO PARA MP/INFUSÃO, SEM REPETIR ATROPINA
- CONSIDERAR MARCA-PASSO TRANSVENOSO EM INSTABILIDADE REFRATÁRIA

TAQUIARRITMIAS

AVALIAÇÃO INICIAL
→ ECG 12 DERIVAÇÕES + MONITORIZAÇÃO + ACESSO IV + OXIGÊNIO SE HIPOXEMIA
IDENTIFICAR QRS:

- ESTREITO: < 0,12S
- LARGO: ≥ 0,12S

TAQUICARDIA INSTÁVEL (LOA PRESENTE)
→ CARDIOVERSÃO ELÉTRICA SINCRONIZADA (CVE)

- RITMO ESTREITO REGULAR: 50-100 J
- RITMO ESTREITO IRREGULAR: 120-200 J
- RITMO LARGO REGULAR: 100 J
- RITMO LARGO IRREGULAR: TRATAR COMO PCR

SEDAÇÃO PARA CVE

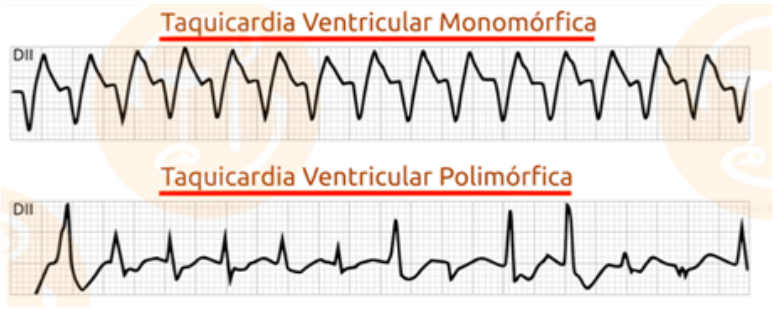
- FENTANIL 1,5 MCG/KG IV
- MIDAZOLAM 0,1–0,2 MG/KG (SE NORMOTENSO)

Disponiibilizado Gratuitamente

- ETOMIDATO 0,1–0,2 MG/KG (SE HIPOTENSO)

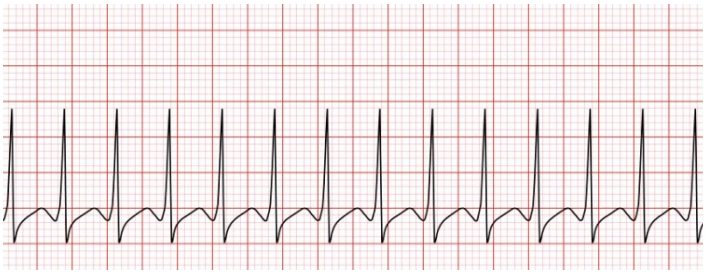
TAQUICARDIA ESTÁVEL

– QRS LARGO



- AMIODARONA
  ATAQUE: 150 MG + 100 ML SG5% EM 10 MIN
  MANUTENÇÃO: 900 MG + 232 ML SG5% EM 24H
  INFUSÃO: 16,6 ML/H POR 6H → 8,3 ML/H POR 18H

QRS ESTREITO + RR REGULAR (EX: TSV)



1. MANOBRAS VAGAIS (VALSALVA, MASSAGEM CAROTÍDEA)
2. ADENOSINA
   - 1ª DOSE: 6 MG IV BÔLUS + FLUSH 20 ML SF0,9%
   - 2ª DOSE: 12 MG IV BÔLUS + FLUSH 20 ML

REFRATÁRIOS:

- METOPROLOL 5 MG IV LENTO (MÁX 15 MG A CADA 15 MIN)
- VERAPAMIL 5 MG/2 ML
  → 0,075-0,15 MG/KG IV
  → INFUSÃO: 0,005 MG/KG/MIN

- DILTIAZEM:
  → 1ª DOSE: 0,25 MG/KG IV

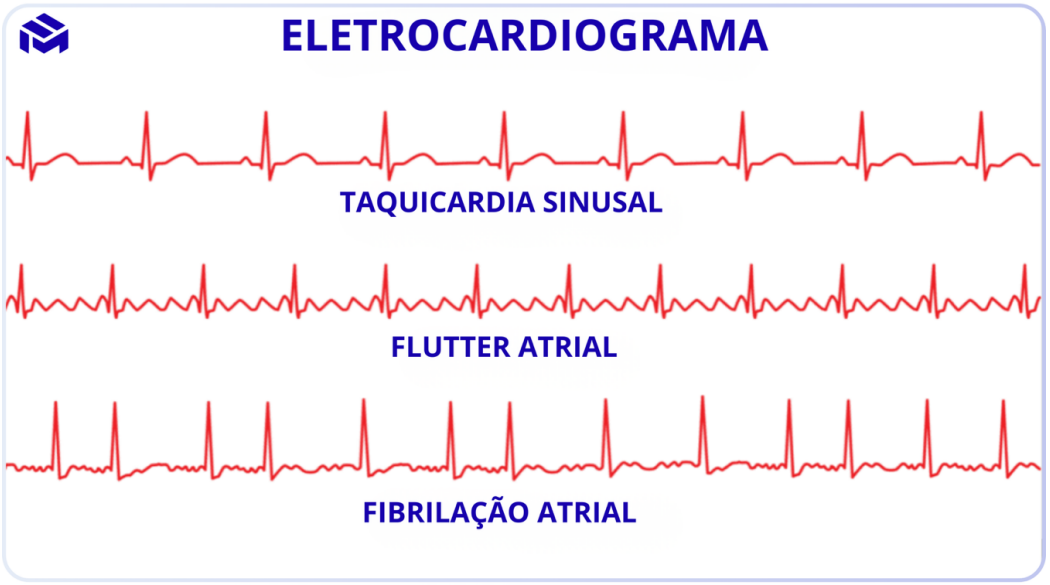
Disponiibilizado Gratuitamente

→ 2ª DOSE: 0,35 MG/KG APÓS 15 MIN

MANUTENÇÃO ORAL – TAQUIARRITMIAS

- PROPRANOLOL 10–40 MG DE 8/8H (MÁX 160 MG/DIA)
- ATENOLOL 25–100 MG/DIA
- VERAPAMIL ATÉ 480 MG/DIA
- DILTIAZEM ATÉ 360 MG/DIA

FIBRILAÇÃO ATRIAL / FLUTTER ATRIAL



INSTÁVEL:
→ CARDIOVERSÃO ELÉTRICA

- *ENERGIA*: 120-200 J BIFÁSICO
- *SEDAÇÃO*: FENTANIL + MIDAZOLAM OU ETOMIDATO

ESTÁVEL (< 48H DE DURAÇÃO):

- ANTICOAGULAR

Disponiibilizado Gratuitamente

- CARDIOVERSÃO (QUÍMICA OU ELÉTRICA)
- MANTER ANTICOAGULAÇÃO POR 4 SEMANAS

ESTÁVEL (> 48H OU TEMPO INCERTO):

- ANTICOAGULAÇÃO POR 3 SEMANAS
- CARDIOVERSÃO APÓS TEE NORMAL
- MANTER ANTICOAGULAÇÃO POR 4 SEMANAS

CONTROLE DA FC (AGUDO IV)

- METOPROLOL 5 MG IV LENTO (MÁX 15 MG)
- VERAPAMIL 2–4 ML + INFUSÃO CONTÍNUA
- DILTIAZEM 0,25 MG/KG → 0,35 MG/KG APÓS 15 MIN

MANUTENÇÃO ORAL:

- METOPROLOL SUCCINATO 25–100 MG/DIA
- PROPRANOLOL 10 MG 8/8H
- VERAPAMIL 120–480 MG/DIA
- DILTIAZEM 60 MG 12/12H (MÁX 360 MG/DIA)

ANTICOAGULAÇÃO

- VARFARINA 2,5-10 MG/DIA (DOSAR INR A CADA 3 DIAS, ATÉ AJUSTE ENTRE 2–3) + HEPARINA/ENOX NO INÍCIO
- ENOXAPARINA 1 MG/KG SC 12/12H
- HNF: ATAQUE 60-70 U/KG → MANUTENÇÃO 12 U/KG/H
- DOACs:
  - DABIGATRANA 11º-150 MG, VO, DE 12/12H.
  - RIVAROXABANA 15 MG,VO, DE 12/12H POR 3 SEM → 20 MG/DIA
  - APIXABANA 5 MG 12/12H (2,5 MG SE >80 ANOS, <60KG OU Cr >1,5)

CARDIOVERSÃO QUÍMICA COM AMIODARONA

- ATAQUE: 150 MG + 100 ML SG5% EM 10 MIN
- MANUTENÇÃO: 900 MG + 250 ML SG5% EM 24H
  → 17,8 ML/H POR 6H → 8,9 ML/H POR 18H

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)

RX DE TÓRAX EVIDENCIANDO AS CORCOVAS DE HAMPTON (BASTANTE ENCONTRADA NA TEP):

Disponiibilizado Gratuitamente

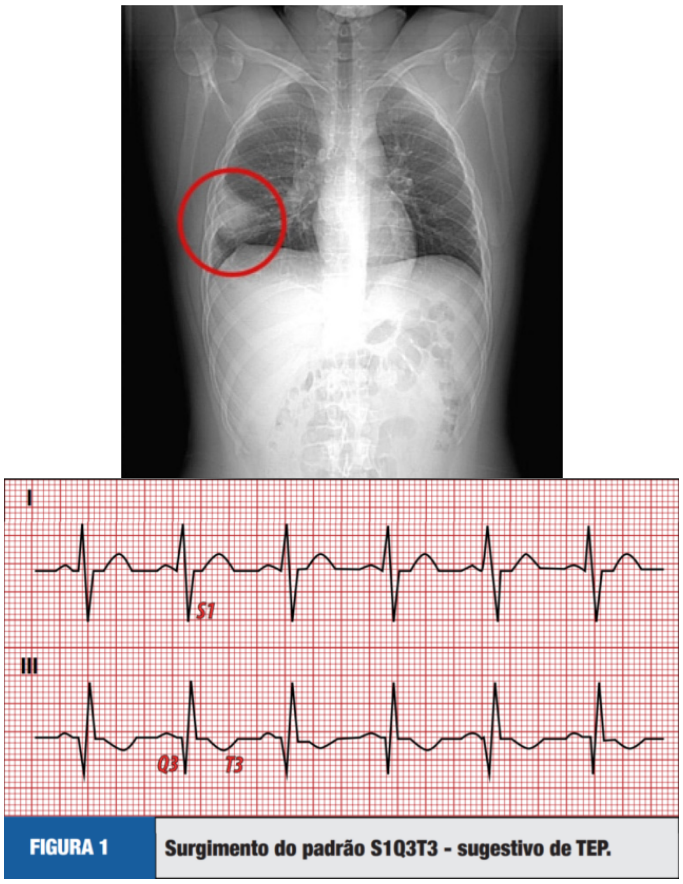


FIGURA 1 Surgimento do padrão S1Q3T3 - sugestivo de TEP.

ANTICOAGULAÇÃO PLENA

- **HEPARINA NÃO FRACIONADA (HNF) IV:** ATAQUE COM 60 UI/KG (MÁX 4000 UI), DEPOIS 12 UI/KG/H (MÁX 1000 UI/H). MANTER TTPA ENTRE 1,5 E 2,0.
- **ENOXAPARINA SC:** 1 MG/KG 12/12H (PACIENTES ≤75 ANOS). SE >75 ANOS → 0,75 MG/KG 12/12H. SE TFG ≤30 ML/MIN → 1 MG/KG 1X/DIA.
- **FONDAPARINUX SC:**
  - 5 MG SE PESO <50 KG
  - 7,5 MG SE PESO ENTRE 50–100 KG
  - 10 MG SE PESO >100 KG

  → 1X/DIA

ANTICOAGULAÇÃO ORAL (MÍNIMO 3 MESES)

- **VARFARINA:** 5 MG/DIA. AJUSTAR PARA INR ENTRE 2–3.
  → ASSOCIAR HNF OU ENOXAPARINA POR PELO MENOS 48H APÓS ALCANÇAR INR TERAPÊUTICO.

DOACs (ANTICOAGULANTES ORAIS DIRETOS)

- **DABIGATRANA:** 150 MG 12/12H (TFG >30 ML/MIN)
- **RIVAROXABANA:** 15 MG 12/12H POR 3 SEMANAS → DEPOIS 20 MG/DIA
- **APIXABANA:** 10 MG 12/12H POR 7 DIAS → DEPOIS 5 MG 12/12H
  → SE IDADE >80 ANOS, CREATININA >1,5 OU PESO <60 KG → REDUZIR PARA

Disponiibilizado Gratuitamente

2,5 MG 12/12H
• **EDOXABANA:** 60 MG/DIA (SE TFG >30 ML/MIN)

TROMBÓLISE (ATÉ 14 DIAS DE SINTOMAS)
• **ESTREPTOQUINASE:**
→ 1.5 MILHÃO UI IV EM 2 HORAS
OU
→ 250 MIL UI EM BÔLUS IV + 100 MIL UI/H POR 24 HORAS

• **ALTEPLASE:**
→ 10 ML EM BÔLUS IV (1–2 MIN) + 90 ML EM 2 HORAS (TOTAL 100 ML)

• **TENECTEPLASE (BÔLUS ÚNICO IV):**
<60 KG: 6 ML
60–70 KG: 7 ML
70–80 KG: 8 ML
80–90 KG: 9 ML
>90 KG: 10 ML

CONTRAINDICAÇÕES À TROMBÓLISE
• ***ABSOLUTAS***:
- AVC HEMORRÁGICO PRÉVIO
- AVC ISQUÊMICO RECENTE (<6 MESES)
- TCE, CIRURGIA OU TRAUMA RECENTE (<3 SEMANAS)
- SANGRAMENTO ATIVO

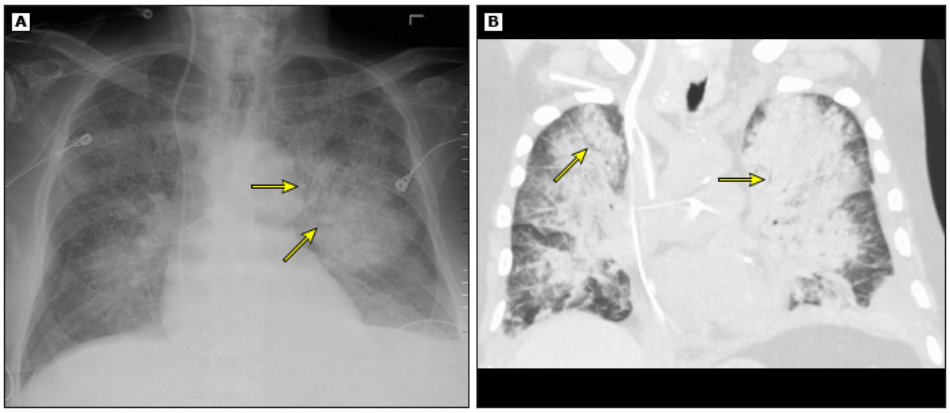
• ***RELATIVAS***:
- AIT <6 MESES
- USO DE ANTICOAGULANTE ORAL
- GRAVIDEZ
- RCP TRAUMÁTICA
- PAS >180 MMHG
- ENDOCARDITE
- ÚLCERA PÉPTICA ATIVA

TROMBECTOMIA MECÂNICA
• ***INDICAÇÕES***:
→ CONTRAINDICAÇÃO À TROMBÓLISE OU
→ FALHA DA TROMBÓLISE COM INSTABILIDADE HEMODINÂMICA

FILTRO DE VEIA CAVA INFERIOR
• ***INDICAÇÕES***:
→ CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA À ANTICOAGULAÇÃO
→ TEP RECORRENTE MESMO COM ANTICOAGULAÇÃO ADEQUADA

Disponiibilizado Gratuitamente

CONGESTÃO PULMONAR / EDEMA AGUDO DE PULMÃO



RX USO EV
1- FUROSEMIDA 20 MG/2 ML (LASIX®) _____ 01 AMP
DOSE: 0,5 A 1 MG/KG IV BOLUS (MÁXIMO 240 MG/DIA)

EXEMPLO PRÁTICO:
50 KG → 2,5 A 5 ML
70 KG → 3,5 A 7 ML
90 KG → 4,5 A 9 ML

2- MORFINA
APRESENTAÇÃO: 2 MG/2 ML _____ 01 AMP
APLICAR 01 AMP IV EM BOLUS LENTO.
PODE REPETIR A CADA 15-30 MIN, SE NECESSÁRIO
OU
APRESENTAÇÃO: 10 MG/1 ML
DILUIR 01 ML EM 09 ML DE AD
ADMINISTRAR 02 ML IV DA SOLUÇÃO, REPETIR SE NECESSÁRIO

3- NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG/2 ML _____ 01 AMP
DILUIR EM 250 ML SF 0,9% – INFUSÃO CONTÍNUA (BIC)
DOSE: 0,3 A 10 MCG/KG/MIN
ATENÇÃO: RISCO DE INTOXICAÇÃO CIANÍDRICA > 3 MCG/KG/MIN

EXEMPLOS DE INFUSÃO (MANTER BOM CONTROLE):
50 KG → 4,5 A 151 ML/H
70 KG → 6,4 A 211 ML/H
90 KG → 8,2 A 272 ML/H

4- NITROGLICERINA 25 MG/5 ML _____ 02 AMP
DILUIR EM 240 ML SF 0,9% – INFUSÃO CONTÍNUA (BIC)
DOSE: INICIAR EM 1,5 ML/H (≈ 5 MCG/MIN)
AUMENTAR GRADUALMENTE A CADA 5 MIN
MÁXIMO: 60 ML/H (≈ 200 MCG/MIN)

Disponiibilizado Gratuitamente

OXIGENOTERAPIA / VNI (SE DISPONÍVEL)
INDICADA EM: IC DESCOMPENSADA OU EDEMA AGUDO DE PULMÃO
AJUSTES INICIAIS:

- VC: 6 ML/KG (PESO PREDITIVO)
- FLUXO INSPIRATÓRIO: 0,7 A 1 L/MIN/KG
- FR: MODO ESPONTÂNEO
- PEEP / EPAP: 5 A 10 CMH2O
- PS / IPAP: INICIAR EM 0 CMH2O E AJUSTAR CONFORME NECESSÁRIO

INVESTIGAR E TRATAR A CAUSA BASE
• SÍNDROME CORONARIANA AGUDA (IAM)
• INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA
• EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA
• ARRITMIAS

Disponiibilizado Gratuitamente

DOENÇAS ENDOCRINOLÓGICAS

DM DESCOMPENSADA

RX USO SC / EV
1- INSULINA REGULAR _____ FRASCO
ADMINISTRAR SC CONFORME GLICEMIA CAPILAR:

- < 180 MG/DL = 0 UI
- 181 A 200 MG/DL = 2 UI
- 201 A 250 MG/DL = 4 UI
- 251 A 300 MG/DL = 6 UI
- 301 A 350 MG/DL = 8 UI
- 350 MG/DL = 10 UI

2- GLICOSE 50% _____ 04 AMP
FAZER 40 ML EV SE GLICEMIA < 70 MG/DL

3- GLICEMIA CAPILAR _____
REALIZAR DE 6/6H

DIABÉTICO + HIPERGLICEMIA (G > 250)

RX USO SC / EV
1- INSULINA REGULAR _____ FRASCO
ADMINISTRAR SC 08 UI AGORA, SE GLICEMIA > 250 MG/DL

2- SE GLICEMIA ≥ 500-600 MG/DL OU "HI":

- **SF 0,9% 500 ML _____ ABERTO**

- APÓS INFUSÃO, ADMINISTRAR INSULINA REGULAR 12 UI SC→ REAVALIAR EM 40 MIN→ SE MELHORA CLÍNICA: REPETIR MAIS 01 FRASCO DE SF 0,9% 500 ML

Disponiibilizado Gratuitamente

HIPOGLICEMIA

QUADRO LEVE *(Paciente consciente, capaz de deglutir)*

- INGESTÃO DE CARBOIDRATOS DE RÁPIDA ABSORÇÃO

OPÇÕES (ESCOLHER UMA):

- **150 mL de refrigerante comum** (não diet);
- **200 mL de suco de laranja natural**;
- **3 sachês de açúcar (5 g cada)** diluídos em **200 mL de água**.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

- Reavaliar glicemia capilar após **15 minutos**.
- Se glicemia < 70 mg/dL, **repetir a ingestão**.
- Após normalização, oferecer **carboidrato de absorção lenta** (lanche/refeição).

QUADRO MODERADO A GRAVE *(Paciente inconsciente, confuso ou sem via oral segura)*

USO ENDOVENOSO (EV)

1. GLICOSE 50% (5 G / 10 ML)——————————————————— AMPOLAS
ADMINISTRAR 04 AMPOLAS EV EM BÓLUS. (TOTAL: 20 G DE GLICOSE).

SEM ACESSO VENOSO DISPONÍVEL:

USO INTRAMUSCULAR (IM)

1. GLUCAGON 1 MG / 1 ML——————————————————— 01 AMPOLA
ADMINISTRAR 1 A 2 ML IM, DOSE ÚNICA.

TIAMINA (PREVENÇÃO DE ENCEFALOPATIA DE WERNICKE). INDICAR PRINCIPALMENTE EM:

- Etilistas
- Desnutridos
- Pacientes com risco nutricional

Disponiibilizado Gratuitamente

RX USO EV OU IM (DOSE DE ATAQUE)

1. TIAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG / 1 ML———————————————
ADMINISTRAR 300 MG (3 ML) DILUÍDOS EM 100 ML DE SG 5% EV, OU ADMINISTRAR 3 ML IM.

RX USO EV (DOSE DE MANUNTENÇÃO)

1. TIAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG / 1 ML———————————————
ADMINISTRAR 100 MG (1 ML) DILUÍDOS EM 100 ML DE SG 5% EV, A CADA 8/8 HORAS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **Tiamina deve ser administrada antes ou junto da glicose** em pacientes de risco.
- Previne encefalopatia de Wernicke.
- Medida simples, segura e essencial no pronto atendimento.

Disponiibilizado Gratuitamente

DOENÇAS INFECCIOSAS

DENGUE

DENGUE CLÁSSICA:

FEBRE ALTA SÚBITA +/MIALGIA/ DOR RETRO-OCULAR/ ASTENIA/ NÁUSEAS/VÔMITOS/ EXANTEMA ESCARLATINIFORME OU MACULOPAPULAR/HEPATOMEGALIA DOLOROSA/DIARREIA/ SINTOMAS RESPIRATÓRIOS.

DENGUE COM SINAIS DE ALERTA / HEMORRÁGICA:

FEBRE + PLAQUETOPENIA/ HEMOCONCENTRAÇÃO/ TENDÊNCIA HEMORRÁGICA
→ CHOQUE PODE OCORRER NO 4º AO 5º DIA DE FEBRE

INDICAÇÕES GERAIS DE INTERNAÇÃO:

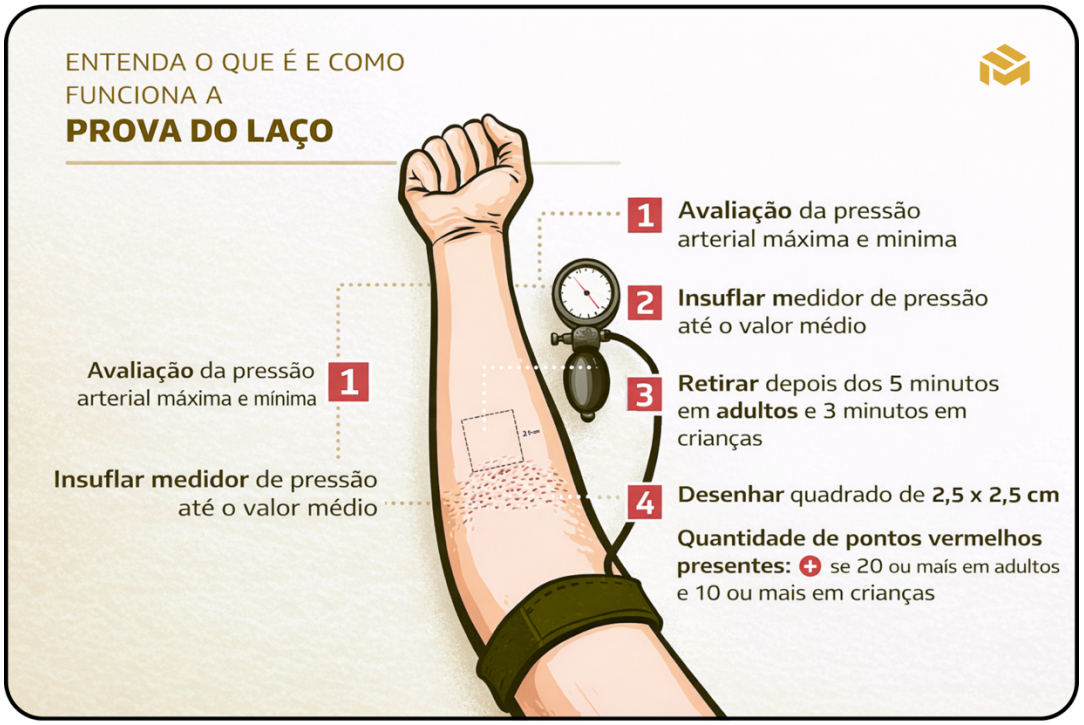
- PRESENÇA DE PELO MENOS UM SINAL DE ALERTA
- PLAQUETAS < 100.000 (PRINCIPALMENTE < 50.000)
- HEMOCONCENTRAÇÃO: HEMATÓCRITO > 50% OU AUMENTO > 10-20% EM RELAÇÃO AO INICIAL

SINAIS DE ALERTA:

- DOR ABDOMINAL CONTÍNUA
- VÔMITOS PERSISTENTES
- HEPATOMEGALIA DOLOROSA
- DERRAMES CAVITÁRIOS (PLEURAL, PERICÁRDICO, ASCITE)
- PULSO FRACO E RÁPIDO
- EXTREMIDADES FRIAS
- HIPOTENSÃO ARTERIAL
- AUMENTO SÚBITO DO HEMATÓCRITO
- LETARGIA OU LIPOTÍMIA
- SANGRAMENTOS IMPORTANTES (GENGIVAL, URINÁRIO, DIGESTIVO)

PROVA DO LAÇO (TOURNIQUET TEST):

Disponiibilizado Gratuitamente



GRUPO A – SEM COMORBIDADES OU SINAIS DE ALARME

RX USO ORAL
1- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

3- SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COPO APÓS CADA EVACUAÇÃO OU EPISÓDIO DE VÔMITO, MÍNIMO 10 COPOS/DIA
OPÇÃO CASEIRA: 01 SACHÊ DILUÍDO EM 1L DE ÁGUA FILTRADA OU FERVIDA

GRUPO B – COM COMORBIDADES OU PROVA DO LAÇO POSITIVA

MESMA PRESCRIÇÃO DO GRUPO A
CONDUTA ADICIONAL:

- SOLICITAR HEMOGRAMA E TESTE RÁPIDO
- SE HEMATÓCRITO ALTERADO:
  INFUNDIR SORO RINGER LACTATO 20 ML/KG EV EM 4 HORAS

GRUPO C – COM SINAIS DE ALARME

Disponiibilizado Gratuitamente

- INTERNAÇÃO POR NO MÍNIMO 48H
- SOLICITAR: HMG, ELETRÓLITOS, ENZIMAS HEPÁTICAS, COAGULOGRAMA, GASOMETRIA, RX TÓRAX E USG DE ABDOME
- INFUSÃO INICIAL: SORO RINGER LACTATO 10 A 20 ML/KG EV EM 1 HORA
- SE MELHORA: MANUTENÇÃO COM SF 0,9% + SG 5%
- SE PIORA: REPETIR EXPANSÃO OU TRATAR COMO GRUPO D

GRUPO D – CHOQUE HIPOTENSIVO

- INTERNAÇÃO EM UTI
- DOIS ACESSOS VENOSOS CALIBROSOS
- INFUNDIR SRL 20 ML/KG EV EM 20 MINUTOS (ATÉ 3 REPETIÇÕES)
- SUPORTE VENTILATÓRIO
- MONITORAR HEMATÓCRITO, DIURESE E SINAIS VITAIS
- AVALIAR NECESSIDADE DE TRANSFUSÕES: CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, PLASMA FRESCO CONGELADO, PLAQUETAS

CRITÉRIOS DE ALTA HOSPITALAR

- PACIENTE AFEBRIL POR 48 HORAS
- HEMATÓCRITO E PLAQUETAS ESTÁVEIS
- MELHORA CLÍNICA GLOBAL
- SEM SINAIS DE ALARME OU INSTABILIDADE

CHIKUNGUNYA

QUADRO CLÍNICO

- FEBRE ALTA (> 38,5°C) + POLIARTRALGIA INTENSA E SIMÉTRICA (LIMITANTE)
  - DURAÇÃO: DIAS A SEMANAS, PODENDO PERSISTIR POR MESES
  - EXANTEMA MACULOPAPULAR (COM OU SEM)
  - PERÍODO DE INCUBAÇÃO: 3 A 7 DIAS
    → SUSPEITAR EM VIAJANTES DE ÁREAS ENDÊMICAS NAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
    → RARAS MANIFESTAÇÕES HEMORRÁGICAS
    → EVOLUÇÃO PARA GRAVIDADE É INCOMUM

MANEJO CLÍNICO

- TRATAMENTO SINTOMÁTICO

Disponiibilizado Gratuitamente

- EVITAR O USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) EM CRIANÇAS (RISCO DE SÍNDROME DE REYE)
- ANTI-INFLAMATÓRIOS PODEM SER USADOS EM CASOS REFRACTÁRIOS, COM CAUTELA

Rx USO ORAL
1- PARACETAMOL 750 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H. INTERCALAR COM DIPIRONA, SE NECESSÁRIO.
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H
TOMAR 01 COPO D'ÁGUA 10 VEZES AO DIA OU MAIS, CONFORME ACEITAÇÃO
3- PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 6/6H

ZIKA VÍRUS

CRITÉRIOS CLÍNICOS (PRESENÇA DE 2 DOS 4 A SEGUIR):
• FEBRE BAIXA (37,8 A 38,5°C)
• EXANTEMA MACULOPAPULAR (GERALMENTE APARECE NO 2º DIA)
• CONJUNTIVITE NÃO PURULENTA
• ARTRALGIA LEVE (PRINCIPALMENTE EM MÃOS E PÉS)

MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS (DE 4 A 20 DIAS APÓS O INÍCIO DA FEBRE):
• MENINGOENCEFALITE
• SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
OBSERVAÇÕES:
• CHOQUE E MANIFESTAÇÕES HEMORRÁGICAS SÃO MUITO RAROS
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL (ATÉ O 7º DIA DE SINTOMAS):
• RT-PCR
• SOROLOGIA POR ELISA

Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H. INTERCALAR COM PARACETAMOL, SE NECESSÁRIO
2- PARACETAMOL 750 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H.
3- HIDROXIZINA 25 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA OU VERMELHIDÃO NA PELE, PODENDO REPETIR DE 08/08H

TOMAR 01 COPO D'ÁGUA 10 VEZES AO DIA OU MAIS, CONFORME ACEITAÇÃO.
NÃO TOMAR ASPIRINA, IBUPROFENO, DICLOFENACO NEM QUALQUER

Disponiibilizado Gratuitamente

OUTRA MEDICAÇÃO SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

OTITE EXTERNA AGUDA (OEA)

Rx USO TÓPICO AUDITIVO
1- CIPROFLOXACINO-DEXAMETASONA SOLUÇÃO TÓPICA _____ 01 FRASCO
PINGAR 04 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO DE 12/12H POR 07 DIAS

USO ORAL
2- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

OU
Rx USO TÓPICO AUDITIVO
1- SULFATO DE NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA B + HIDROCORTISONA 11% SOLUÇÃO TÓPICA _____ 01 FRASCO
PINGAR 04 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO DE 06/06H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 05:00 - 11:00 - 17:00 - 23:00

USO ORAL
2- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

OU
Rx USO TÓPICO AUDITIVO
1- OTOSPORIN _____ 01 FRASCO
PINGAR 04 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO DE 06/06H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 05:00 - 11:00 - 17:00 - 23:00

USO ORAL
2- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

Disponiibilizado Gratuitamente

OTITE MÉDIA AGUDA (OMA ou AOM)

Rx USO ORAL
1- AMOXICILINA 500 MG _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 14:00 / 22:00
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

OU
Rx USO ORAL
1- AMOXICILINA 875mg + CLAVULANATO 125mg _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

FARINGOAMIGDALITE INESPECÍFICA

Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
2- BENALET _____ 01 CAIXA
DISSOLVER LENTAMENTE UMA PASTILHA NA BOCA, PODENDO REPETIR DE 2/2H CONFORME NECESSIDADE

FARINGOAMIGDALITE ESTREPTOCÓCICA

Rx USO ORAL
1- AMOXICILINA 500MG _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 08/08H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 14:00 / 22:00
2- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
3- OMEPRAZOL 20 MG _____ 128 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ EM JEJUM, 30 MINUTOS ANTES DO CAFÉ-DA-MANHÃ, POR 10 DIAS

Ou

Rx USO ORAL

1- AZITROMICINA 500MG _____ 05 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00
2- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H
3- OMEPRAZOL 20 MG _____ 128 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ EM JEJUM, 30 MINUTOS ANTES DO CAFÉ-DA-MANHÃ, POR 10 DIAS

INTERTRIGO - CANDIDÍASE

Rx USO ORAL
1- FLUCONAZOL 150mg _____ 04 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 07 DIAS ATE O TOTAL DE 04 DOSES

USO TÓPICO
2- TROK-N _____ 01 BISNAGA
APLICAR NAS LESÕES DUAS VEZES AO DIA ATÉ MELHORA
LAVAR A REGIÃO AFETADA COM ÁGUA E SABÃO E SECAR BEM EM SEGUIDA
EVITAR AO MÁXIMO O USO DE CALÇADOS FECHADOS
Ou

Rx USO ORAL
1- ITRACONAZOL 100mg _____ 10 CÁPSULAS
TOMAR 01 CÁPSULA DE 12/12H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 08h00 - 20h00

USO TÓPICO
2- TROK-N _____ 01 BISNAGA
APLICAR NAS LESÕES DUAS VEZES AO DIA ATÉ MELHORA
LAVAR A REGIÃO AFETADA COM ÁGUA E SABÃO E SECAR BEM EM SEGUIDA
EVITAR AO MÁXIMO O USO DE CALÇADOS FECHADOS

Disponiibilizado Gratuitamente

SISTEMA URINÁRIO

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (CISTITE NÃO COMPLICADA)

Primeira linha de tratamento
Rx USO ORAL
1- SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400/80 MG _____ 12 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12H POR 03 DIAS
Ou
Rx USO ORAL
1- SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400/80 MG _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12H POR 05 DIAS
Ou
Rx USO ORAL
1- FOSFOMICINA GRANULADO 3 G _____ 01 CAIXA
DILUIR O ENVELOPE EM UM COPO D'ÁGIA E INGERIR EM DOSE ÚNICA
Ou
1- NITROFURANTOÍNA 100 MG _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 06/06H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00

Segunda linha de tratamento
Rx USO ORAL
1- NORFLOXACINO 400 MG _____ 06 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 03 DIAS
Ou
Rx USO ORAL
1- NORFLOXACINO 400 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
Ou
Rx USO ORAL
1- CIPROFLOXACINO 500 MG _____ 06 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 03 DIAS
Ou
Rx USO ORAL
1- CIPROFLOXACINO 500 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 10 DIAS

CÓLICA NEFRÉTICA

INDICAÇÕES DE INTERNAÇÃO:

1. INFECÇÃO ASSOCIADA COM FEBRE
2. SINTOMAS DE SEPSE
3. INCAPACIDADE DE CONTROLE DA DOR

Disponiibilizado Gratuitamente

4. DÚVIDA DIAGNÓSTICA (IDOSOS)
5. QUADRO OBSTRUTIVO (RIM ÚNICO / TRANSPLANTADO)

EXAMES COMPLEMENTARES A SEREM CONSIDERADOS:
• EAS (HEMATÚRIA EM 90% DOS CASOS)
• HMG, U, Cr, ELETRÓLITOS (SE INFECÇÃO, OLIGÚRIA OU INTERNAÇÃO)
• USG ABDOMINAL: AVALIA DILATAÇÃO / LOCALIZA CÁLCULO
• TC HELICOIDAL: EXAME MAIS SENSÍVEL
• RX DE ABDOME: AVALIA CÁLCULOS RADIOPACOS (NÃO MUDA MANEJO NA EMERGÊNCIA)

PRESCRIÇÃO PADRÃO
– RX USO INJETÁVEL

1. DIPIRONA 1G/2ML _____ 01 AMP + 10 ML AD, EV, A CADA 6/6H, SE DOR
2. CETOPROFENO 100 MG _____ 01 AMP + 100 ML SF 0,9%, EV, A CADA 8/8H
3. ESCOPOLAMINA (BUSCOPAN) 20 MG/ML _____ 01 AMP + 8 ML AD, EV, A CADA 8/8H SE ESPASMO
4. TRAMADOL 50 MG/ML _____ 02 AMP + 100 ML SF 0,9%, EV LENTO, A CADA 8/8H SE DOR INTENSA
5. ONDANSETRONA 4 MG/2ML _____ 01 AMP, EV, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

SE CÁLCULO ENTRE 0,5 E 1,0 CM:
6. TANSULOSINA 0,4 MG _____ 01 CP VO À NOITE, POR 7 A 14 DIAS

– CÓLICA NEFRÉTICA NA SALA DE EMERGÊNCIA

RX USO EV

1. **CETOROLACO 30 MG/ML _____ 01 AMP + 100 ML SF 0,9%, EV, AGORA**
   AINES DE ESCOLHA PARA DOR AGUDA INTENSA

SE DOR INTENSA OU REFRATÁRIA A AINES: ASSOCIAR OPIÓIDE

2. **MORFINA 10 MG/1 ML _____ DILUIR 1 ML EM 9 ML DE AD**
ADMINISTRAR 2 A 5 ML DA SOLUÇÃO, IV LENTO, REPETIR APÓS 15-30 MIN SE NECESSÁRIO

Rx USO ORAL

Disponiibilizado Gratuitamente

1- CETOPROFENO 150 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 12/12H POR ATÉ 05 DIAS SEGUIDO
2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H
BEBER BASTANTE ÁGUA E DIMINUIR A INGESTA DE SÓDIO E PROTEÍNAS (EX: EVITAR CARNES, SAL E REFRIGERANTES)

Ou

Rx USO ORAL
1- CETOROLACO 10 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
DISSOLVER 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL, PODENDO REPETIR DE 6/6H POR ATÉ 05 DIAS SEGUIDOS
2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H
BEBER BASTANTE ÁGUA E DIMINUIR A INGESTA DE SÓDIO E PROTEÍNAS (EX: EVITAR CARNES, SAL E REFRIGERANTES)

Ou

Rx USO ORAL
1- ALGICOD _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO JUNTO COM DICLOFENACO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 8/8H SE NECESSÁRIO. TOMAR O MÍNIMO POSSÍVEL, PARA EVITAR DEPENDÊNCIA E CONSTIPAÇÃO
2- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO JUNTO COM ALGICOD, SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 8/8H, POR ATÉ 05 DIAS SEGUIDOS
3- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

BEBER BASTANTE ÁGUA E DIMINUIR A INGESTA DE SÓDIO E PROTEÍNAS (EX: EVITAR CARNES, SAL E REFRIGERANTES)

SOLICITAR: USG DE RINS E VIAS URINÁRIAS + FÍGADO E VIAS BILIARES
JUSTIF: NEFROLITÍASE?//URETEROLITÍASE?///COLELITÍASE?

SE CÁLCULO ENTRE 0,5 e 1 cm::
RX USO ORAL
- TANSULOSINA 0,4 MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO APÓS O CAFÉ DA MANHÃ, POR 04 SEMANAS

Disponiibilizado Gratuitamente

PIELONEFRITE

Não complicada
Rx USO ORAL
1- CIPROFLOXACINO 500 MG _____ 14 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS SEGUIDOS///HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

Ou
Rx USO ORAL
1- LEVOFLOXACINO 750 MG _____ 07 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA, NO MESMO HORPARIO, POR 07 DIAS SEGUIDOS

Complicada
CEFTRIAXONA 01 GRAMA EV, OU UMA DOSE DE AMINOGLICOSÍDEO EV, SEGUIDA DE:
Rx USO ORAL
1- CIPROFLOXACINO 500 MG _____ 14 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00
Ou

Rx USO ORAL

1- LEVOFLOXACINO 750 MG _____ 07 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA, NO MESMO HORPARIO, POR 07 DIAS SEGUIDOS

DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS

CÁLCIO

– HIPOCALCEMIA SINTOMÁTICA
RX USO EV
1- GLUCONATO DE CÁLCIO 10% _____ 01 A 02 AMPOLAS + 100 ML SF 0,9%
INFUNDIR IV EM 20 MINUTOS. REPETIR SE NECESSÁRIO.

– MANUTENÇÃO EM HIPOCALCEMIA SEVERA
RX USO EV
1- GLUCONATO DE CÁLCIO 10% _____ 11 AMPOLAS + 1000 ML SF 0,9%
CORRER EM BIC A 50 ML/H

Disponiibilizado Gratuitamente

FÓSFORO

– HIPOFOSFATEMIA
RX USO EV
1- FOSFATO DE POTÁSSIO 20% _____ 01 A 02 AMPOLAS
→ PERIFÉRICO: DILUIR EM 500 ML SF, CORRER EM 6 HORAS
→ CENTRAL: DILUIR EM 250 ML SF, CORRER EM 3 HORAS

MAGNÉSIO

– HIPOMAGNESEMIA
RX USO EV
1- SULFATO DE MAGNÉSIO 10% / 20% / 50% _____ 01 A 02 AMPOLAS + 100 ML SF 0,9%
CORRER IV CONFORME NECESSIDADE:
• <1,0 MG/DL → 4 A 8 G EM 12–24H
• 1,0–1,5 MG/DL → 2 A 4 G EM 4–12H
• 1,6–1,9 MG/DL → 1 A 2 G EM 1–2H

POTÁSSIO

– HIPOCALEMIA GRAVE (<3,0 mEq/L)
RX USO EV
1- CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% _____ 16 ML + 500 ML SF 0,9% (PERIFÉRICO)
INFUNDIR EM 4 HORAS (MÁX. 10 mEq/h)

2- CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% _____ 10 ML + 250 ML SF 0,9% (CENTRAL)
INFUNDIR EM 2 HORAS (MÁX. 20 mEq/h)

–HIPOCALEMIA LEVE (>3,0 mEq/L)
RX USO ORAL
1- CLORETO DE POTÁSSIO 6% (XAROPE) _____ 12 mEq A CADA 15 ML
2- CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG (CÁPSULA) _____ 08 mEq POR CÁPSULA
TOMAR 10 A 20 mEq DE 2 A 4 VEZES AO DIA

HIPERCALEMIA (MANEJO COMPLETO)
RX USO EV / INALATÓRIO

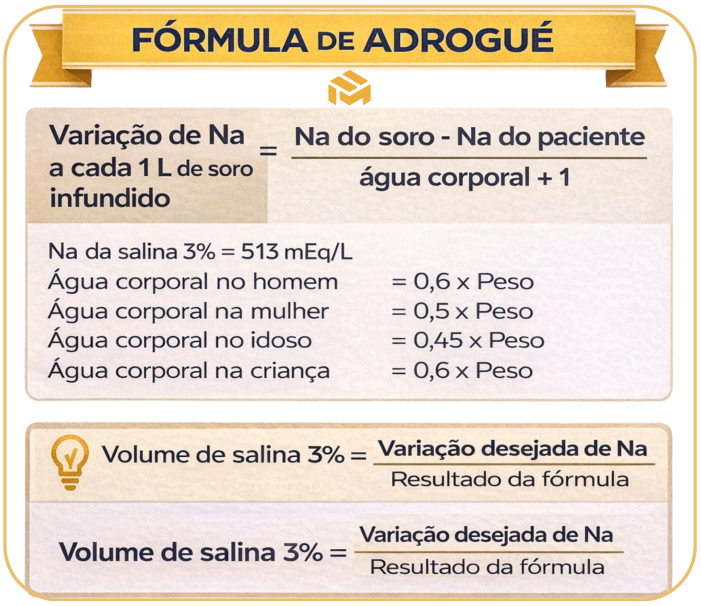
Disponiibilizado Gratuitamente

1- GLUCONATO DE CÁLCIO 10% + 100 ML SF _____ IV EM 5–10 MIN (SE ECG ALTERADO)
2- INSULINA REGULAR 10 UI + SG 10% 500 ML _____ INFUNDIR IMEDIATO (OU SG 50% 100 ML + AD)
3- SALBUTAMOL INALATÓRIO _____ 10 GOTAS + 5 ML SF 0,9%, INALAR
4- BICARBONATO DE SÓDIO 1 MEQ/KG _____ IV (SE ACIDOSE GRAVE)
5- FUROSEMIDA 40 MG _____ IV (EXCETO EM IR GRAVE)
6- SORCAL 30 G + 100 ML MANITOL _____ IV (CADA VEZ MENOS USADO)
7- HEMODIÁLISE URGENTE _____ SE REFRATÁRIO

SÓDIO

– HIPONATREMIA / HIPERNATREMIA
• CONCENTRAÇÃO DE Na NAS SOLUÇÕES:
SF 0,9% → 154 MEQ/L
SF 3% → 513 MEQ/L
SF 20% → 3,4 MEQ/ML
RL → 130 MEQ/L
SG → SEM SÓDIO

- **COMO PREPARAR SF 3% CASEIRO**
  → 445 ML SF 0,9% + 55 ML SF 20%
- **CORREÇÃO DE Na – FÓRMULA DE ANDROGUE:**
  ΔNA = (NA SOLUÇÃO – NA PACIENTE) / (ÁGUA CORPORAL + 1)



- **REGRAS PRÁTICAS:**
  • NÃO VARIAR >10 MEQ/L EM 24H
  • SE HIPONATREMIA AGUDA SINTOMÁTICA → CORRIGIR 4–6 MEQ/L EM 3H
  • DOSAR Na DE FORMA SERIADA DURANTE INFUSÃO

Disponiibilizado Gratuitamente

SEPSE:

DEFINIÇÃO	Sepsis-2 (2012)	Sepsis-3 (2016)
SEPSE	**SIRS + suspeita de infecção** **Critérios de SIRS:** • Temperatura > 38 °C ou < 36 °C • Frequência cardíaca > 90 bpm • Frequência respiratória > 20 irpm ou $PaCO_2$ < 32 mmHg • Leucócitos < 4.000 ou > 12.000 ou > 10% de bastões	**Suspeita de infecção + disfunção orgânica** • Aumento de ≥ 2 pontos no SOFA *OU* • Presença de 2 ou 3 critérios do qSOFA
SEPSE GRAVE	**Sepse + disfunção orgânica**, como: • PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg • Lactato > 2 mmol/L • INR > 1,5 • Bilirrubina > 2 mg/dL • Débito urinário < 0,5 mL/kg/h por ≥ 2 h • Creatinina > 2 mg/dL • Plaquetas < 100.000 • $SatO_2$ < 90% em AA	• Definição abolida
CHOQUE SÉPTICO	**Sepse + hipotensão refratária à reposição volêmica**	**Sepse + necessidade de vasopressores** • Lactato > 2 mmol/L -->Após reanimação volêmica adequada

MEDIDAS INICIAIS:

1. ACESSO VENOSO CALIBROSO X2
2. OXIGÊNIO SE SAT O_2 < 92%
3. ***REPOSIÇÃO VOLÊMICA:***
   • SF 0,9% OU RINGER LACTATO 30 ML/KG NAS PRIMEIRAS 3H
   • REAVALIAR COM ALÍQUOTAS DE 250–500 ML

DROGAS VASOPRESSORAS:

1. NORADRENALINA 4 MG/4 ML
   • DILUIR 2 AMP + 250 ML SG5%
   • INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): 0,05 A 2,0 MCG/KG/MIN
2. VASOPRESSINA 20 UI/ML
   • DILUIR 1 AMP + 100 ML SF
   • INFUSÃO CONTÍNUA: 0,01 A 0,04 U/MIN (ASSOCIAR SE NORA > 0,25–0,5 MCG/KG/MIN)

HIDROCORTISONA 50 MG (1 ML) + 100 ML SG5%.
• INFUSÃO IV DE 6/6H SE PAM PERSISTIR < 65 MMHG

METAS TERAPÊUTICAS:
• PAM > 65 MMHG

Disponiibilizado Gratuitamente

• DÉBITO URINÁRIO > 0,5 ML/KG/H
• TEC < 3 SEGUNDOS

EXAMES INICIAIS:
• HEMOCULTURAS (2 PARES ANTES DE ATB)
• GASOMETRIA COM LACTATO
• HEMOGRAMA, FUNÇÃO RENAL, GLICEMIA, URINA 1, PCR, PROCALCITONINA, TGO/TGP, COAGULOGRAMA, ECG, RX TÓRAX

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA (CONFORME FOCO):

- PULMONAR: CEFTRIAXONA 2G IV 24/24H + CLARITROMICINA 500 MG IV 12/12H
  OU CLINDAMICINA 600 MG IV 6/6H (SE PNEUMONIA ASPIRATIVA).
- URINÁRIO: CEFTRIAXONA 2G IV 24/24H
- ABDOMINAL: PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4G + 0,5G IV 6/6H
- PELE/PARTES MOLES: OXACILINA 2G IV 4/4H + CLINDAMICINA 600 MG IV 6/6H
- SEM FOCO DEFINIDO:CEFEPIME 2G IV 8/8H + METRONIDAZOL 500 MG IV 8/8H

Disponiibilizado Gratuitamente

DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E ALÉRGICAS

ERISIPELA E CELULITE NA EMERGÊNCIA

- Agentes mais comuns: Streptococcus pyogenes (β-hemolítico do grupo A), seguido pelo Staphylococcus aureus – mas lembre-se que casos mais resistentes podem ser causados por Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (SARM ou MRSA).

- *Primeira linha terapêutica:*
  - Cefalosporinas de primeira geração ou Amoxicilina- Clavulonato (Cobrem tanto os Estrepto como os Estafilococos)
  - Na celulite, o tratamento deve durar entre 5 a 10 dias, já na erisipela é de 10 a 14 dias, e o ATB deve ser mantido por pelo menos 3 dias após a redução do processo inflamatório
  - Na ausência de melhora após 24 a 36 horas do início do ATB, solicitar culturas e antibiogramas, além de considerar MRSA
  - Evitar AINES, pois podem mascarar os sinais e sintomas de infecções necrotizantes profundas

RX USO ORAL
1- CEFALEXINA 500MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 07 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00
MANTER O MEMBRO ELEVADO NA MAIOR PARTE DO TEMPO E APLICAR COMPRESSAS MORNAS
Ou

RX USO ORAL
1- CEFALEXINA 500MG _____ 40 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00

MANTER O MEMBRO ELEVADO NA MAIOR PARTE DO TEMPO E APLICAR COMPRESSAS MORNAS
Ou

RX USO ORAL
1- CEFALEXINA 500MG _____ 56 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 14 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00
MANTER O MEMBRO ELEVADO NA MAIOR PARTE DO TEMPO E APLICAR COMPRESSAS MORNAS

Opção para alérgicos à betalactâmicos:
RX USO ORAL
1- CLINDAMICINA 300mg _____ 42 CÁPSULAS
TOMAR 02 CÁPSULAS DE 8/8 HORAS POR 07 DIAS

Disponiibilizado Gratuitamente

HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 14:00 / 22:00

Obs: Na Erisipela, considerar internação se < 2 anos ou imunocomprometidos.

ALERGIA E PRURIDO

Anti-histamínicos são muito mais eficientes e seguros no controle de urticária isolada, mesmo em monoterapia. Evitar uso rotineiro de corticoides.

ALERGIA- MAIS BARATO

Rx USO ORAL

1- HIDROXIZINA 25mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS

2- PREDNISONA 20mg _____ 10 COMPRIMIDOS TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 08:00 DA MANHÃ POR 05 DIAS

Ou

Rx USO ORAL

1-LORATADINA 25 MG _____01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS

APÓS ESTE PERÍODO, TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA OU ESPIRROS, PODENDO REPETIR A DOSE 24/24H SE NECESSÁRIO

2- PREDNISONA 20mg _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 08:00 DA MANHÃ POR 05 DIAS

ALERGIA- MÉDIO

Rx USO ORAL

1-CETIRIZINA 10mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS

APÓS ESTE PERÍODO, TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA OU ESPIRROS, PODENDO REPETIR A DOSE 24/24H SE NECESSÁRIO

Disponiibilizado Gratuitamente

2- PREDNISONA 20mg _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 08:00 DA MANHÃ POR 05 DIAS

ALERGIA- MAIS CARO

Rx USO ORAL

1- LEVOCETIRIZINA 5mg_____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS

APÓS ESTE PERÍODO, TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA OU ESPIRROS, PODENDO REPETIR A DOSE 24/24H SE NECESSÁRIO

2- PREDNISONA 20mg _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 08:00 DA MANHÃ POR 05 DIAS

ALERGIA- ESPIRROS

Rx USO ORAL

1- FEXOFENADINA 60mg + PSEUDOEFEDRINA 120mg _____ 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE ESPIRROS OU CORIZA, PODENDO REPETIR DE 12/12H

HERPES ZÓSTER

Rx USO ORAL
1- ACICLOVIR 400 MG _____ 70 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 4/4H, EXCETUANDO-SE UMA DOSE NOTURNA, POR 07 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 – 10:00 – 14:00 – 18:00 – 22:00
2- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 – 14:00 – 22:00
3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H SE NECESSÁRIO

USO TÓPICO
4- DIPROGENTA _____ 01 BISNAGA

Disponiibilizado Gratuitamente

APLICAR NA LESÃO DUAS VEZES AO DIA ATÉ MELHORA

Ou

Rx USO ORAL
1- ACICLOVIR 400 MG _____ 70 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 4/4H, EXCETUANDO-SE UMA DOSE NOTURNA, POR 07 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 – 10:00 – 14:00 – 18:00 – 22:00
2- PREDNISONA 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00
3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H SE NECESSÁRIO

USO TÓPICO
4- DIPROGENTA _____ 01 BISNAGA
APLICAR NA LESÃO DUAS VEZES AO DIA ATÉ MELHORA

ÚLCERAS DE CAUSAS VARIADAS

Rx USO TÓPICO
1- CLORANFENICOL + COLAGENASE POMADA 0,6 U/g + 0,01 g/g _____ 01 BISNAGA
APÓS LAVAR COM ÁGUA E SABÃO E SECAR BEM, APLICAR UMA FINA CAMADA NA LESÃO E COBRIR COM CURATIVO COM GAZE DUAS VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA.

Ou

Rx USO TÓPICO
1- IRUXOL POMADA _____ 01 BISNAGA
APÓS LAVAR COM ÁGUA E SABÃO E SECAR BEM, APLICAR UMA FINA CAMADA NA LESÃO E COBRIR COM CURATIVO COM GAZE DUAS VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA

USO ORAL
2- CEFALEXINA 500MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 07 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00
3- DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG _____ 14 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

Disponiibilizado Gratuitamente

ESCABIOSE

Rx USO ORAL
1- IVERMECTINA 6 MG _____ 04 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA E REPETIR APÓS 21 DIAS
2- HIDROXIZINA 25 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS
TROCAR ROUPAS DE CAMA DIARIAMENTE DURANTE OS 3 PRIMEIROS DIAS DE TRATAMENTO

FURÚNCULO

RX USO ORAL
1- IBUPROFENO 600 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 5 DIAS

RX USO TÓPICO
2- MUPIROCINA 2% POMADA _____ 01 BISNAGA
APLICAR UMA CAMADA FINA SOBRE A LESÃO 3X/DIA POR 7 DIAS

SE FEBRE OU SINAIS SISTÊMICOS:
RX USO ORAL
3- CEFALEXINA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 7 DIAS

IMPETIGO CROSTOSO

Rx USO TÓPICO
1- MUPIROCINA POMADA 2% _____ 01 BISNAGA
APLICAR NAS LESÕES TRÊS VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA
LAVAR COM ÁGUA MORNA E SABÃO DUAS A TRÊS VEZES AO DIA
TENTAR REMOVER AS CROSTAS ANTES DE APLICAR A POMADA – SE HOUVER DIFICULDADE, PODE-SE AMOLECÊ-LAS APLICANDO PRIMEIRO ÓLEO OU VASELINA LIGEIRAMENTE AQUECIDA
Ou

RX USO ORAL
1- CEFALEXINA 500MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 07 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00
USO TÓPICO
2- MUPIROCINA POMADA 2% _____ 01 BISNAGA
APLICAR NAS LESÕES TRÊS VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA
LAVAR COM ÁGUA MORNA E SABÃO DUAS A TRÊS VEZES AO DIA

TENTAR REMOVER AS CROSTAS ANTES DE APLICAR A POMADA – SE HOUVER DIFICULDADE, PODE-SE AMOLECÊ-LAS APLICANDO PRIMEIRO ÓLEO

Disponiibilizado Gratuitamente

OU VASELINA LIGEIRAMENTE AQUECIDA

MICOSE SUBUNGUEAL E PAQUIONÍQUIA

Rx USO TÓPICO
1- UREIA MANIPULADA EM CREME 40% _____ 01 FRASCO
APLICAR UMA CAMADA SOB A UNHA À NOITE ANTES DE DORMIR, COM O AUXÍLIO DE UM COTONETE OU UM CHUMAÇO DE ALGODÃO, E LAVAR BEM PELA MANHÃ, COM ÁGUA E SABÃO
2- NITRATO DE OXICONAZOL 10mg/ml _____ 01 FRASCO
APLICAR 01 CAMADA SOB A UNHA PELA MANHÃ, COM O AUXÍLIO DE COTONETE OU UM CHUMAÇO DE ALGODÃO, PELA MANHÃ, APÓS LAVAR COM ÁGUA E SABÃO DURANTE O BANHO, POR 01 A 02 SEMANAS

NASOFARINGITE AGUDA – RESFRIADO COMUM

Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H

USO INTRANASAL
2- SERINGA DE 10 ML _____ 01 UNIDADE
3- SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% _____ 01 FRASCO
ASPIRAR O SORO COM A SERINGA, RETIRAR A AGULHA E INJETAR EM CADA NARINA (SEM TAPAR A OUTRA), ESTANDO COM A BOCA ABERTA, TRÊS VEZES AO DIA
É NORMAL ENGOLIR OU A SECREÇÃO SAIR PELO OUTRO LADO

ECZEMA DE CONTATO

Caso leve

RX USO TÓPICO

1- BETAMETASONA 0,1% _____ 01 BISNAGA
APLICAR UMA FINA CAMADA SOBRE A ÁREA AFETADA DUAS VEZES AO DIA

USO ORAL

Disponiibilizado Gratuitamente

2- LORATADINA 25 MG _____01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS

APÓS ESTE PERÍODO, TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA, PODENDO REPETIR A DOSE 24/24H SE NECESSÁRIO

Caso intenso

RX USO TÓPICO

1- CLOBETAZOL CREME 0,5 mg/g _____ 01 BISNAGA
APLICAR UMA FINA CAMADA SOBRE A ÁREA AFETADA DUAS VEZES AO DIA

USO ORAL

2- LORATADINA 25 MG _____01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS

APÓS ESTE PERÍODO, TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA, PODENDO REPETIR A DOSE 24/24H SE NECESSÁRIO

HORDÉOLO VOLUMOSO / BLEFARITE INTENSA

Rx USO TÓPICO

1- CIPROFLOXACINO 1mg/mL + DEXAMETASONA 3mg/mL POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL _____ 01 BISNAGA

APLICAR NA BORDA DOS CÍLIOS AFETADOS TRÊS VEZES AO DIA POR 15 DIAS

APLICAR COMPRESSAS DE ÁGUA MORNA TRÊS VEZES AO DIA

TINHA CAPITIS

Rx USO ORAL

1- GRISEOFULVINA 500mg _____ 50 COMPRIMIDOS

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 8 SEMANAS

USO TÓPICO

2- CETOCONAZOL SHAMPOO 2% _____ 01 FRASCO

APLICAR NO COURO CABELUDO, DEIXAR AGIR POR 10 MINUTOS ANTES DE ENXAGUAR, 2 A 3 VEZES POR SEMANA, DURANTE 4 SEMANAS

TINHA CORPORIS

Rx USO ORAL
1- TERBINAFINA 250mg _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 28 DIAS SEGUIDOS

2- CETIRIZINA 10 mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA OU ALERGIA, PODENDO REPETIR DE 24/24 SE NECESSÁRIO

USO TÓPICO

3- TERBINAFINA CREME 1% _____ 01 BISNAGA
APLICAR NAS ÁREAS AFETADAS DE 12/12H ATÉ MELHORA (EM MÉDIA 28 DIAS)

QUEIMADURAS

Rx USO TÓPICO

1- SULFADIAZINA DE PRATA 10mg/g _____ 01 BISNAGA
APLICAR UMA CAMADA NA LESÃO E COBRIR COM CURATIVO COM GAZE, DUAS VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA

USO ORAL

2- DIPIRONA 500MG _____ 01 CAIXA

Disponiibilizado Gratuitamente

TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 06/06H

SUTURA:

ANTIBIOTICOTERAPIA PROFILÁTICA EM FERIDAS COM MENOS DE 6 HORAS.

Indicada nos seguintes casos:

- Feridas que afetam tendões//Feridas que atingem articulações, cavidade torácica, abdominal ou encéfalo//Feridas grosseiramente contaminadas (ex: terra, fezes)//Feridas puntiformes profundas e penetrantes (ex: arma branca, projétil)//Lesões extensas com tecido desvitalizado//Feridas abdominais com perfuração de alças intestinais//Fraturas expostas.

RX USO ORAL (FERIDAS CONTAMINADAS)

1- CEFALEXINA 500 MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 07 DIAS
HORÁRIOS SUGERIDOS: 06:00 / 12:00 / 18:00 / 00:00

2- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 05 DIAS
HORÁRIOS SUGERIDOS: 06:00 / 14:00 / 22:00

3- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

RX USO TÓPICO (NÃO CONTAMINADAS)
4- SULFATO DE NEOMICINA 3,5 MG/G _____ 01 BISNAGA
APLICAR FINA CAMADA SOBRE A LESÃO APÓS CADA TROCA DE CURATIVO

APÓS 10 DIAS DO TRAUMA (CICATRIZ)
5- CONTRACTUBEX _____ 01 BISNAGA
APLICAR FINA CAMADA NA CICATRIZ 2X/DIA PARA MELHORA ESTÉTICA

RX USO INTRAMUSCULAR (SE INDICADO, PROFILAXIA PARA TÉTANO)
6- TETANOGAMMA 250 UI _____ 01 AMPOLA
APLICAR 01 AMPOLA IM NO GLÚTEO MÉDIO

Disponiibilizado Gratuitamente

SISTEMA NERVOSO E PSIQUIÁTRICO

CEFALEIAS PRIMÁRIAS

Analgesia geral

Rx USO ORAL
1- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS VO SE FEBRE OU DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H

2- NAPROXENO SÓDICO 500 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR UM COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 12/12H POR ATÉ 05 DIAS SEGUIDOS

3- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

CEFALEIA TENSIONAL

RX USO ORAL
1- CEFALIUM _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR DE CABEÇA, PODENDO REPETIR A CADA 6 HORAS, SE NECESSÁRIO

2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

SE TONTURA:
3- CINARIZINA 25 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 3 DIAS

CONVULSÃO

RX USO ORAL
1- DIAZEPAM 10 MG/2 ML _____ 01 AMPOLA
INFUNDIR 01 AMPOLA EV, PURA, EM CASO DE CONVULSÃO COM DURAÇÃO > 5 MINUTOS.

PODE REPETIR UMA VEZ SE NECESSÁRIO (CASO NÃO HAJA RESPOSTA NA PRIMEIRA DOSE, APÓS ISSO, CASO NÃO RESPONDA, OUTRAS DROGAS DEVEM SER USADAS.

OU

Disponiibilizado Gratuitamente

1- MIDAZOLAM 5 MG/ML _____ 01 AMPOLA
APLICAR 3 ML IM SE DIFICULDADE DE ACESSO VENOSO DURANTE A CONVULSÃO.

DEPRESSÃO

Rx USO ORAL
1- TIAMINA 300 mg _____ 60 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 7 DIAS, DEPOIS 01 COMPRIMIDO AO DIA
HORÁRIO SUGERIDO (12/12h): 08:00 / 20:00

2- DIAZEPAM 10 mg _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR, POR 20 DIAS SEGUIDOS

3- AMITRIPTILINA 25 mg _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR

LABIRINTITE

RX USO ORAL
1- BETAHISTINA 16 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H OU 12/12H, POR 7 A 10 DIAS

OU

1- CINARIZINA 25 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, APÓS AS REFEIÇÕES, POR 5 A 7 DIAS

OU

1- CINARIZINA 75 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, APÓS O JANTAR, POR 7 A 10 DIAS

OU

1- FLUNARIZINA 10 MG (VERTIX) _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 7 DIAS, DEPOIS 01 COMPRIMIDO AO DIA POR MAIS 14 DIAS

2- ONDANSETRONA 4 MG (VONAU) _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL DE 8/8H EM CASO DE NÁUSEAS OU VÔMITOS.

Disponiibilizado Gratuitamente

AVC HEMORRÁGICO

1. MANEJO INICIAL

- MOV + GLICEMIA CAPILAR + ESCALA DE CINCINNATI
- TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE
- EXAMES: HMG, COAGULOGRAMA, ELETRÓLITOS, FUNÇÃO RENAL, ECG
- OBJETIVOS CLÍNICOS:
  - PAS ≤ 140 MMHG (INTRAPARENQUIMATOSA)
  - PAS ≤ 160 MMHG (HSA)
  - GLICEMIA 80-180 MG/DL
  - SAT O_2 ≥ 94%
  - TEMPERATURA < 37,5ºC

2. CONTROLE DA PA

- **NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG/2 ML** _____ 1 AMP + 250 ML SF 0,9% EM BIC
  DOSE: 0,3 A 10 MCG/KG/MIN

3. REVERSÃO DA ANTICOAGULAÇÃO

- VARFARINA → FITOMENADIONA 10 MG (1 AMP) + 50 ML SF 0,9%, IV EM 30 MIN
- PLASMA FRESCO CONGELADO → 10 A 20 ML/KG EV 8/8H
  CCP (CONC. DE COMPLEXO PROTROMBÍNICO):
  - INR 2–3 → 25 UI/KG
  - INR 4–6 → 35 UI/KG
  - INR >6 → 45 UI/KG
  - HEPARINA → PROTAMINA 50 MG/5 ML _____ 0,1 ML PARA CADA 100 UI DE HEPARINA, MÁXIMO 50 MG

4. VASOESPASMO (HSA)

- **NIMODIPINO 30 MG** _____ TOMAR 60 MG VO OU SNG DE 4/4H

5. CONVULSÕES (HSA)

- FENITOÍNA 250 MG
  ATAQUE: 20 MG/KG EV EM 30–60 MIN
  MANUTENÇÃO: 100–125 MG EV DE 8/8H

Disponiibilizado Gratuitamente

AVC ISQUÊMICO

1. MANEJO INICIAL

- MOV + GLICEMIA CAPILAR + ESCALA DE CINCINNATI
- TC CRÂNIO SEM CONTRASTE
- EXAMES: HMG, COAGULOGRAMA, ELETRÓLITOS, FUNÇÃO RENAL, ECG

2. TROMBÓLISE (SE INDICADO)

- ALTEPLASE: 0,9 MG/KG (MÁX. 90 MG) → 10% EM BOLUS + 90% EM BIC 60 MIN

3. CRITÉRIOS PARA TROMBÓLISE

- IDADE ≥ 18 ANOS
- NIHSS SIGNIFICATIVO OU AFASIA PURA
- INÍCIO < 4H30
- TC SEM SANGRAMENTO OU ÁREAS GRANDES DE HIPODENSIDADE

4. EXCLUSÕES

- AVC/TCE RECENTE
- HIC PRÉVIA OU NEOPLASIA INTRA-AXIAL
- CIRURGIA INTRACRANIANA
- INR > 1,7 / TTPA > 40 S
- ENOXA TERAPÊUTICA < 24H
- PA > 185/110

5. SEM TROMBÓLISE

- AAS 300 MG ATAQUE (3 CP), 100 MG DIA
- ENOXAPARINA 40 MG SC 1X/DIA
  - (20 MG/DIA SE TFG < 30)
  - OMEPRAZOL 20 MG JEJUM

  PA ALVO: ≤ 220/120 MMHG

  SAT O_2 ≥ 94% | GLICEMIA 100–180

6. PÓS-TROMBÓLISE

- CABECEIRA 0º + HIDRATAÇÃO
- AAS, ANTICOAGULANTE, ACESSOS → CONTRAINDICADOS NAS 1ª 24H
- MONITORAR: PA < 185/105 | GLICEMIA 100–180 | TEMPERATURA < 37,5ºC
- PROFILAXIA: OMEPRAZOL + ESTATINA + INVESTIGAR CAUSA (ECG, DOPPLER)

Disponiibilizado Gratuitamente

SOLUÇO + VÔMITOS (SEQUELAS DE AVCI)

• CLORPROMAZINA (AMPLICTIL) – TOMAR 5 GOTAS, VO, 12/12H OU 1/3 DE AMPOLA, EV, AGORA

ESQUIZOFRENIA

Rx USO ORAL
1) FLUOXETINA 20 mg _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ, EM DIAS ALTERNADOS, DURANTE 10 DIAS EM SEGUIDA, TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ CONTINUAMENTE Rx USO ORAL

2) CITALOPRAM 20 mg _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR, CONTINUAMENTE

PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA (DE BELL)

Rx USO ORAL
1- VALACICLOVIR 500 MG _____ 42 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 8/8H, POR 07 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 – 14:00 – 22:00
2- PREDNISONA 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00

USO TÓPICO
3- LACRIMA PLUS _____ 01 FRASCO
PINGAR UMA GOTA NO OLHO PARALISADO, DE 30/30 MINUTOS
4- REGENOM _____ 01 FRASCO
APLICAR NO OLHO PARALISADO À NOITE, ANTES DE DORMIR, E COBRIR COM CURATIVO OCLUSIVO (GAZE E ESPARADRAPO, SEM APERTAR)
PRATICAR FISIOTERAPIA FACIAL SEMPRE QUE POSSÍVEL: FAZER CARETAS, BIQUINHOS, ASSOPRAR, FECHAR OS OLHOS COM FORÇA, FALAR NORMALMENTE... – PROCURAR UM PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA OU DE FONOAUDIOLOGIA EM CASO DE DIFICULDADE

Síndrome de Ramsay Hunt

Rx USO ORAL
1- ACICLOVIR 400 MG _____ 70 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 4/4H, EXCETUANDO-SE UMA DOSE NOTURNA,

Disponiibilizado Gratuitamente

POR 07 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 – 10:00 – 14:00 – 18:00 – 22:00
2- PREDNISONA 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00

USO TÓPICO
3- LACRIMA PLUS _____ 01 FRASCO
PINGAR UMA GOTA NO OLHO PARALISADO, DE 30/30 MINUTOS
4- REGENOM _____ 01 FRASCO
APLICAR NO OLHO PARALISADO À NOITE, ANTES DE DORMIR, E COBRIR COM CURATIVO OCLUSIVO (GAZE E ESPARADRAPO, SEM APERTAR)
PRATICAR FISIOTERAPIA FACIAL SEMPRE QUE POSSÍVEL: FAZER CARETAS, BIQUINHOS, ASSOPRAR, FECHAR OS OLHOS COM FORÇA, FALAR NORMALMENTE... – PROCURAR UM PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA OU DE FONOAUDIOLOGIA EM CASO DE DIFICULDADE

ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA

INTRA-HOSPITALAR – ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA

- SUSPEITOU DE ABSTINÊNCIA, ESTRATIFICAR GRAVIDADE PELO CIWA-AR
- RESULTADO:
  - < 15: TRATAMENTO DOMICILIAR
  - > 15: INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Disponiibilizado Gratuitamente

Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised (CIWA-Ar)

Nome: _____ Data: _____
Pulso ou FC: _____ PA: _____ Hora: _____

1. Você sente um mal estar no estômago (enjôo)? Você tem vomitado? ☐
0 Não
1 Náusea leve e sem vômito
4 Náusea recorrente com ânsia de vômito
7 Náusea constante, ânsia de vômito e vômito

2. Tremor com os braços estendidos e os dedos separados: ☐
0 Não
1 Não visível, mas sente
4 Moderado, com os braços estendidos
7 Severo, mesmo com os braços estendidos

3. Sudorese: ☐
0 Não
4 Facial
7 Profusa

4. Tem sentido coceiras, sensação de insetos andando no corpo, formigamentos, pinicações? Código da questão 8 ☐

5. Você tem ouvido sons a sua volta? Algo perturbador, sem detectar nada por perto? Código da questão 8 ☐

6. As luzes têm parecido muito brilhantes? De cores diferentes? Incomodam os olhos? Você tem visto algo que tem lhe perturbado? Você tem visto coisas que não estão presentes? ☐
0 Não
1 Muito leve
2 Leve
3 Moderado
4 Alucinações moderadas
5 Alucinações graves
6 Extremamente graves
7 Contínua

7. Você se sente nervoso (a)? (observação) ☐
0 Não
1 Muito leve
4 Leve
7 Ansiedade grave, um estado de pânico, semelhante a um episódio psicótico agudo?

8. Você sente algo na cabeça? Tontura, dor, apagamento? ☐
0 Não
1 Muito leve
2 Leve
3 Moderado
4 Moderado / grave
5 Grave
6 Muito grave
7 Extremamente grave

9. Agitação: (observação) ☐
0 Normal
1 Um pouco mais que a atividade normal
4 Moderadamente
7 Constante

10. Que dia é hoje? Onde você está? Quem sou eu? (observação) ☐
0 Orientado
1 Incerto sobre a data, não responde seguramente
2 Desorientado com a data, mas não mais do que 2 dias
3 Desorientado com a data, com mais de 2 dias
4 Desorientado com o lugar e pessoa

Escore_____

PESQUISAR POR QUE O PACIENTE PAROU DE BEBER:
- ANAMNESE
- LABORATÓRIO: IONOGRAMA, CPK, FUNÇÃO HEPÁTICA, FUNÇÃO RENAL, ECG

TRATAMENTO:
- TIAMINA + COMPLEXO B + ÁCIDO FÓLICO
- GLICOSE
- DIAZEPAM (ALTA DOSE, PODENDO SER 500 MG OU MAIS POR DIA): OBJETIVANDO UM CIWA-AR < 8
- SE REFRATÁRIO AO DIAZEPAM: UTILIZAR FENOBARBITAL

NÃO USAR: FENITOÍNA / HALOPERIDOL

EXTRA-HOSPITALAR – CONDUTA ADAPTADA

RX USO ORAL
1- TIAMINA 300 MG _____ 60 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS, DEPOIS 01 COMPRIMIDO AO DIA
HORÁRIO SUGERIDO (12/12H): 08:00 / 20:00

2- CARBAMAZEPINA 200 MG _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H

ENCAMINHAMENTO – MODELO DE TEXTO

Disponiibilizado Gratuitamente

À UNIDADE DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA:
CARO COLEGA,
PACIENTE DEU ENTRADA NESTE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA COM SINAIS DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA, SENDO INICIADO TRATAMENTO PROFILÁTICO PARA SÍNDROME DE WERNICKE.
FAVOR, PRESCREVER CARBAMAZEPINA 200 MG DE 12/12H ATÉ CONSULTA COM PSIQUIATRA, SE ASSIM CONCORDAR APÓS SUA AVALIAÇÃO.

CONDUTA IDEAL (RECOMENDADA COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO)

RX USO ORAL
1- TIAMINA 300 MG _____ 60 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS, DEPOIS 01 COMPRIMIDO AO DIA
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

2- DIAZEPAM 10 MG _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR, POR 20 DIAS SEGUIDOS

3- AMITRIPTILINA 25 MG _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR.
RETORNAR AO PSF APÓS 21 DIAS DE TRATAMENTO PARA REAVALIAÇÃO

ALTERNATIVA COM ISRS (SE PREDOMÍNIO ANSIOSO OU DEPRESSIVO)
(IMPORTANTE EXCLUIR TRANSTORNO BIPOLAR ANTES DE INICIAR ISRS)

RX USO ORAL
1- TIAMINA 300 MG _____ 60 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS, DEPOIS 01 COMPRIMIDO AO DIA
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

2- DIAZEPAM 10 MG _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR, POR 20 DIAS SEGUIDOS

3- FLUOXETINA 20 MG _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ
RETORNAR AO PSF APÓS 21 DIAS DE TRATAMENTO PARA REAVALIAÇÃO

OUTRA OPÇÃO COM ISRS

RX USO ORAL
1- TIAMINA 300 MG _____ 60 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 07 DIAS, DEPOIS 01 COMPRIMIDO AO DIA
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

2- DIAZEPAM 10 MG _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR, POR 20 DIAS SEGUIDOS

Disponiibilizado Gratuitamente

3- CITALOPRAM 20 MG _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, ANTES DE DORMIR
RETORNAR AO PSF APÓS 21 DIAS DE TRATAMENTO PARA REAVALIAÇÃO

CALMANTES FITOTERÁPICOS

Rx USO ORAL
1- PASSÍFLORA 260 mg _____ 20 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 10 DIAS
ou
Rx USO ORAL
1- PASSÍFLORA INCARNATA 360 mg _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE POR 30 DIAS

Rx USO ORAL
1- PASSÍFLORA INCARNATA 360 mg _____ 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS, E DEPOIS UM COMPRIMIDO À NOITE POR MAIS 10 DIAS
ou
Rx USO ORAL
1- PASSÍFLORA INCARNATA 500 mg _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO 01 VEZ À NOITE POR 10 DIAS

CATATONIA, ACATISIA, AGITAÇÃO

1) RINGER OU SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, EV, ABERTO; GLICOSE 50% _____ 02 AMP, EV;
2) COMPLEXO B _____ 04 AMP, EV, BOLUS LENTO. NÃO DILUIR; HALOPERIDOL 5MG/ML - 01 AMP, IM;
3) PROMETAZINA 25MG/ML _____02 AMP, IM;
DIAZEPAM 5MG/ML - 02 AMP, IM; CLORPROMAZINA 25MG/5ML - 01 AMP, IM.

SURTO PSICÓTICO- MANIA - AGRESSIVIDADE

1) CONTENÇÃO FÍSICA, SN;
2) HALOPERIDOL 5MG - 01 AMP, IM. REPETIR A CADA HORA, SN; PROMETAZINA 25MG/ML _____ 01 AMP, IM (DELTÓIDE).
3) CLORPROMAZINA 25MG/5ML - 01 AMP, IM.
4) OLANZAPINA 10MG - 01 AMP, IM.
5) COMPLEXO B - 01 AMP + 10 ML AD, EV;
6) SG 5%, 1000ML, EV.
7) DIAZEPAM 10MG/2ML – 01 AMP + 10 ML AD, EV, SE AGITAÇÃO MOTORA; HALOPERIDOL 5MG/ML - 01 AMP, IM, SE ALUCINAÇÕES;

Disponiibilizado Gratuitamente

COMA ALCOÓLICO

1) DIETA ORAL ZERO;
2) TIAMINA 100MG _____ 03 AMP + 100 ML DE SF 0,9%, EV;
3) SG 5% 500 ML, EV, EM 6H.
4) GLICOSE HIPERTÔNICA 50% - 04 AMP, EV, SE GC < 70 MG/DL;
5) ONDANSETRONA 2 MG/ML – 01 AMP + 100 ML SF 0,9%, EV, LENTO, 8/8h;
CONSIDERAR AINDA:
6) HALOPERIDOL 5MG/ML + 2 ML, IM;
7) DIAZEPAM 5MG/ML _____ 02 AMP, IM;
8) CLORPROMAZINA _____ 01 AMP, IM, SE AGITAÇÃO;
9) PROMETAZINA 25MG/ML _____ 02 AMP, IM, SE AGITAÇÃO.

CRISE DE ANSIEDADE - PÂNICO

DIAZEPAM 5MG, VO, DOSE ÚNICA; OU DIAZEPAM 10MG/2ML _____01 AMP, IM;

Disponiibilizado Gratuitamente

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

LOMBALGIA MECÂNICA

Rx USO ORAL
1- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
2- PARACETAMOL 350mg + CARISOPRODOL 150mg + CAFEÍNA 50mg_____ 01 CAIXA
TOMAR 2 COMPRIMIDOS SE DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H SE NECESSÁRIO

APLICAR COMPRESSAS DE ÁGUA MORNA TRÊS VEZES AO DIA
SE POSSÍVEL, REALIZAR FISIOTERAPIA COM FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA ABDOMINAL E PARAVERTEBRAL

Ou
Rx USO ORAL
1- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, POR 05 DIAS SEGUIDOS///HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

3- CICLOBENZAPRINA 5 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DORMIR, POR 05 DIAS SEGUIDOS

APLICAR COMPRESSAS DE ÁGUA MORNA TRÊS VEZES AO DIA
SE POSSÍVEL, REALIZAR FISIOTERAPIA COM FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA ABDOMINAL E PARAVERTEBRAL

Ou
Rx USO ORAL
1- ALGINAC 1000 _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00
2- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

3- CICLOBENZAPRINA 5 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DORMIR, POR 05 DIAS SEGUIDOS

APLICAR COMPRESSAS DE ÁGUA MORNA TRÊS VEZES AO DIA
SE POSSÍVEL, REALIZAR FISIOTERAPIA COM FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA ABDOMINAL E PARAVERTEBRAL

Disponiibilizado Gratuitamente

Ou

Rx USO ORAL
1- CELECOXIBE 100 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR UM COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
2- PARACETAMOL 350mg + CARISOPRODOL 150mg + CAFEÍNA 50mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 2 COMPRIMIDOS SE DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H SE NECESSÁRIO

APLICAR COMPRESSAS DE ÁGUA MORNA TRÊS VEZES AO DIA

SE POSSÍVEL, REALIZAR FISIOTERAPIA COM FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA ABDOMINAL E PARAVERTEBRAL

TORCICOLO ESPASMÓDICO

Rx USO ORAL
1- CAFEÍNA 35mg + DIPIRONA 300mg + ORFENADRINA 50mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 6/6H SE DOR
Ou

Rx USO ORAL
1- PARACETAMOL 350mg + CARISOPRODOL 150mg + CAFEÍNA 50mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 2 COMPRIMIDOS SE DOR, DE 6/6H
Ou

Rx USO ORAL
1- CARISOPRODOL 125mg + DICLOFENACO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CAFEÍNA 30mg _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR ATÉ 05 DIAS
Ou

Rx USO ORAL
1- DICLOFENACO 50 MG _____ 15 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 08/08H POR ATÉ 05 DIAS
2- CICLOBENZAPRINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE
Ou

Rx USO ORAL
1- CETOPROFENO 150 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR ATÉ 05 DIAS
2- CICLOBENZAPRINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE POR 05 DIAS
Ou

Disponiibilizado Gratuitamente

Rx USO ORAL
1- NIMESULIDA BETACICLODEXTRINA 400 MG _____ 06 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR ATÉ 03 DIAS
2- CICLOBENZAPRINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE

TRAUMA TORÁCICO – ANALGESIA OTIMIZADA

Rx USO ORAL
1- NAPROXENO 500mg _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS SEGUIDOS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 – 20:00
3- CICLOBENZAPRINA 05mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DORMIR, POR 05 DIAS SEGUIDOS
3- PARACETAMOL 350mg + CARISOPRODOL 150mg + CAFEÍNA 50mg _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR, PODENDO REPETIR DE 6/6H SE NECESSÁRIO
4- CODEÍNA 30mg_____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR INTENSA, PODENDO REPETIR DE 8/8H SE NECESSÁRIO. TOMAR O MÍNIMO POSSÍVEL, PARA EVITAR DEPENDÊNCIA E CONSTIPAÇÃO

BURSITE

USO ORAL – Opção 1

1- CAFEÍNA 35mg + DIPIRONA 300mg + ORFENADRINA 50mg _____ 01 CAIXA
Tomar 02 comprimidos de 6/6h, se dor.

Rx USO ORAL – Opção 2

1- PARACETAMOL 350mg + CARISOPRODOL 150mg + CAFEÍNA 50mg _____ 01 CAIXA
Tomar 02 comprimidos de 6/6h, se dor.

Rx USO ORAL – Opção 3

1- CARISOPRODOL 125mg + DICLOFENACO SÓDICO 50mg + PARACETAMOL 300mg + CAFEÍNA 30mg _____ 10 COMPRIMIDOS
Tomar 01 comprimido de 12/12h por até 05 dias.

Rx USO ORAL – Opção 4

Disponiibilizado Gratuitamente

1- DICLOFENACO SÓDICO 50mg _____ 15 COMPRIMIDOS
Tomar 01 comprimido de 8/8h por até 05 dias.
2- CICLOBENZAPRINA 10mg _____ 01 CAIXA
Tomar 01 comprimido à noite.

Rx USO ORAL – Opção 5

1- NIMESULIDA BETACICLODEXTRINA 400mg _____ 06 COMPRIMIDOS
Tomar 01 comprimido de 12/12h por até 03 dias.
2- CICLOBENZAPRINA 10mg _____ 01 CAIXA
Tomar 01 comprimido à noite.

Rx USO ORAL – Opção 6

1- DICLOFENACO SÓDICO 50mg + TIAMINA 50mg + PIRIDOXINA 50mg + CIANOCOBALAMINA 1000mcg (ALGINAC 1.000) _____ 06 COMPRIMIDOS
Tomar 01 comprimido de 8/8h por 05 dias seguidos.
2- CICLOBENZAPRINA 10mg _____ 01 CAIXA
Tomar 01 comprimido à noite.

Rx USO ORAL – Opção 7 (Sublingual)

1- CETOROLACO TROMETAMINA 10mg SL _____ 06 COMPRIMIDOS
Colocar 01 comprimido sob a língua e esperar dissolver. Repetir de 8/8h por até 03 dias.
2- CICLOBENZAPRINA 10mg _____ 01 CAIXA
Tomar 01 comprimido à noite.

GOTA

AINE – Primeira linha

Rx USO ORAL

1- NAPROXENO SÓDICO 250mg _____ 30 COMPRIMIDOS
Tomar 02 comprimidos de 12/12h por 3 dias
Horário sugerido: 08:00 / 20:00
Depois, tomar 01 comprimido de 8/8h por mais 5 dias
Horário sugerido: 06:00 / 14:00 / 22:00

2- DIPIRONA 500mg _____ 01 CAIXA
Tomar 02 comprimidos se dor ou febre, podendo repetir de 6/6h.

Disponiibilizado Gratuitamente

3- OMEPRAZOL 20mg _____ 10 COMPRIMIDOS
Tomar 01 comprimido pela manhã, em jejum, por 10 dias.

Contraindicação a AINE (úlcera péptica ativa, anticoagulantes, intolerância):

Rx USO ORAL

1- COLCHICINA 0,5mg _____ 90 COMPRIMIDOS
Tomar 02 comprimidos e, após 1 hora, mais 01 comprimido.
Em seguida, manter 01 comprimido de 8/8h por 03 meses.

Ajuste de dose se ClCr < 30mL/min: usar metade da dose
Contraindicada em disfunção hepática grave
Dose máxima: 1.500mg/dia
Dialíticos: dose única de 0,6mg

Contraindicação a AINE e COLCHICINA:

Rx USO ORAL

1- PREDNISONA 20mg _____ 31 COMPRIMIDOS
Tomar 01 comprimido de 8/8h por 07 dias, depois 12/12h por 04 dias, e então 01 vez ao dia, às 08:00, por mais 03 dias.

Observação importante: Nunca iniciar ou suspender hipouricemiantes durante uma crise de gota.

Disponiibilizado Gratuitamente

SAÚDE DA MULHER

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA

Rx USO ORAL
1- LEVONORGESTREL 0,75 MG _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR OS DOIS COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA
2- DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA 10MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE VERTIGEM, NÁUSEAS, OU VÔMITO, PODENDO REPETIR DE 6/6H
3- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG __ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H
Ou
1- LEVONORGESTREL 1,5 G _____ 01 COMPRIMIDO
TOMAR UM COMPRIMIDO EM DOSE ÚNICA

DISMENORREIA

Rx USO ORAL
1- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 8/8H
2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

Rx USO ORAL
1- PIROXICAM 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 12/12H POR ATÉ 05 DIAS
2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

Rx USO ORAL
1- MELOXICAM 7,5 MG _____ 05 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 24/24H POR ATÉ 05 DIAS SEGUIDOS
2- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL:

RX USO ORAL
1- ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 8/8H
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 14:00 / 22:00
2- PIROXICAM 20 MG _____ 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 05 DIAS
3- LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15mg + 0,03mg

Disponiibilizado Gratuitamente

_____ 04 CAIXAS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H, POR 04 DIAS;
A SEGUIR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 04 DIAS;
A SEGUIR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 04 DIAS;
E EM SEGUIDA 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 2 MESES.

Se anemia:
- SULFATO FERROSO _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA, 01 HORA ANTES OU 02 HORAS DEPOIS DO ALMOÇO, DE PREFERÊNCIA COM SUCO DE LARANJA OU LIMÃO
SOLICITO: USG PÉLVICA TRANSABDOMINAL E TRANSVAGINAL
JUSTIFICATIVA: SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

VAGINOSE BACTERIANA

Rx USO INTRAVAGINAL
1- METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100mg/g _____ 01 BISNAGA
APLICAR O CONTEÚDO DE UM APLICADOR CHEIO DENTRO DA VAGINA, À NOITE AO DEITAR, POR 14 DIAS

EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA, PARA A “VAGINA RESPIRAR”
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS

CANDIDÍASE

Rx USO INTRAVAGINAL
1- NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/g _____ 01 BISNAGA
APLICAR O CONTEÚDO DE UM APLICADOR CHEIO DENTRO DA VAGINA, À NOITE AO DEITAR, POR 14 DIAS
Ou

USO ORAL
1- FLUCONAZOL 150 MG _____ 01 COMPRIMIDO
TOMAR EM DOSE ÚNICA

EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA, PARA A “VAGINA RESPIRAR”
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS

Disponiibilizado Gratuitamente

TRICOMONÍASE

Rx USO ORAL
1- METRONIDAZOL 250 MG _____ 08 COMPRIMIDOS
TOMAR 08 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA
Ou
1- METRONIDAZOL 250 MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12h POR 07 DIAS

USO INTRAVAGINAL
2- METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100mg/g _____ 01 BISNAGA
APLICAR O CONTEÚDO DE UM APLICADOR CHEIO DENTRO DA VAGINA, À NOITE AO DEITAR, POR 07 NOITES
EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA, PARA A "VAGINA RESPIRAR"
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS

SOLICITO:
- TESTE RÁPIDO PARA HIV
- HBsAg,Anti-HBs, Anti-HBc IgM e IgG
- Anti-HCV
- VDRL

GONORREIA

– Na ausência de laboratório, é precido tratar Clamídia e Gonococo
Rx USO ORAL
1- AZITROMICINA 500 MG _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA
2- CIPROFLOXACINO 500 MG _____ 01 COMPRIMIDO
TOMAR 01 COMPRIMIDO EM DOSE ÚNICA

EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA, PARA A "VAGINA RESPIRAR"
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS

SOLICITO:
- TESTE RÁPIDO PARA HIV
- HBsAg,Anti-HBs, Anti-HBc IgM e IgG
- Anti-HCV

Disponiibilizado Gratuitamente

- VDRL e FTA-Abs

CANCRO MOLE

Rx USO ORAL
1- AZITROMICINA 500 MG _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS VO EM DOSE ÚNICA
Ou

Rx USO INTRAMUSCULAR
1- CEFTRIAXONA 500 MG _____ 01 AMPOLA
APLICAR EM GLÚTEO MÉDIO
EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA, PARA A "VAGINA RESPIRAR"
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS

LINFOGRANULOMA VENÉREO

Rx USO ORAL
1- DOXICICLINA 100 MG _____ 42 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 21 DIAS
Ou
Rx USO ORAL
1- AZITROMICINA 500 MG _____ 06 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS A CADA 07 DIAS ATÉ 03 DOSES
EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)

NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA, PARA A "VAGINA RESPIRAR"
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS
SOLICITO:
- TESTE RÁPIDO PARA HIV
- HBsAg,Anti-HBs, Anti-HBc IgM e IgG
- Anti-HCV
- VDRL

SÍFILIS

Rx USO INTRAMUSCULAR

Disponiibilizado Gratuitamente

1- PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI ___ 02 AMPOLAS
APLICAR UMA AMPOLA EM CADA GLÚTEO MÉDIO
Ou
1- PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI ___ 06 AMPOLAS
APLICAR UMA AMPOLA EM CADA GLÚTEO MÉDIO, A CADA 07 DIAS, ATÉ COMPLETAR TRÊS DOSES
Ou
Rx USO ORAL
1- DOXICILINA 100 MG _____ 56 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 28 DIAS

SOLICITO:
- TESTE RÁPIDO PARA HIV
- HBsAg,Anti-HBs, Anti-HBc IgM e IgG
- Anti-HCV
- VDRL

HERPES GENITAL

Rx USO ORAL
1- ACICLOVIR 200 MG _____ 50 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 4/4H, EXCETUANDO-SE UMA DOSE NOTURNA, POR 10 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00 / 22:00

Profilaxia (indicada se > 6 episódios/ano):
1- ACICLOVIR 200 MG _____ TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H

DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA AGUDA (DIP)

TRATAMENTO PADRÃO

RX USO INTRAMUSCULAR
1- CEFTRIAXONA 500 MG _____ 01 AMP
ADMINISTRAR DOSE ÚNICA, IM, NA REGIÃO GLÚTEA

RX USO ORAL
2- DOXICICLINA 100 MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 14 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 08:00 / 20:00

3- METRONIDAZOL 250 MG _____ 84 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 8/8H POR 14 DIAS
HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 14:00 / 22:00

Disponiibilizado Gratuitamente

4- DIPIRONA 500 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

5- METOCLOPRAMIDA 10 MG _____ 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

SOLICITAÇÕES COMPLEMENTARES

- SOROLOGIAS: HIV, HTLV, HBSAG, ANTI-HBS, ANTI-HBC (IGM E IGG), ANTI-HCV, VDRL
- USG PÉLVICA TRANSABDOMINAL E TRANSVAGINAL

REAVALIAÇÃO
RETORNAR EM 03 DIAS PARA AVALIAÇÃO DE RESPOSTA CLÍNICA
SE MELHORA: MANTER ESQUEMA
SE SEM MELHORA: CONSIDERAR INTERNAÇÃO OU ENCAMINHAR À REFERÊNCIA GINECOLÓGICA

MODELO DE ENCAMINHAMENTO
-CARO COLEGA,

A PACIENTE SUPRACITADA FOI AVALIADA POR MIM NESTA UNIDADE NO DIA ___, COM QUADRO CLÍNICO COMPATÍVEL COM DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA.

FOI INICIADA ANTIBIOTICOTERAPIA COM:
• CEFTRIAXONA 500 MG IM (DOSE ÚNICA)
• DOXICICLINA 100 MG VO 12/12H POR 14 DIAS
• METRONIDAZOL 250 MG VO 8/8H POR 14 DIAS
• SINTOMÁTICOS

SOLICITO REAVALIAÇÃO CLÍNICA EM 03 DIAS:
• SE HOUVER MELHORA: MANTER O ESQUEMA
• SE SEM RESPOSTA: CONSIDERAR INTERNAÇÃO OU ENCAMINHAR À REFERÊNCIA

AGRADEÇO SUA ATENÇÃO.

ABUSO SEXUAL

Rx IM

1- PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI _____ 02 AMPOLAS
APLICAR UMA AMPOLA EM CADA GLÚTEO MÉDIO
2- CEFTRIAXONA 500 MG _____ 01 AMPOLA

Disponiibilizado Gratuitamente

APLICAR EM GLÚTEO MÉDIO

USO ORAL
3- AZITROMICINA 500 MG _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR OS 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA
4- METRONIDAZOL 250 MG _____ 08 COMPRIMIDOS
TOMAR 08 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA
5- - LEVONORGESTREL 0,75 MG _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR OS DOIS COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

Vacinação antitetânica + Imunoglobulina antitetânica + Profilaxia pós-exposição ao HIV

Disponiibilizado Gratuitamente

HEMOTRANSFUSÃO

1. CONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CH)

INDICAÇÕES:

- HB < 7,0 G/DL (PACIENTE NORMOVOLÊMICO)
- HB < 8,0 G/DL (PÓS-OP OU DOENÇA CARDIOVASCULAR)
- HB < 7,5 G/DL EM HEMORRAGIA DIGESTIVA
- CHOQUE HEMORRÁGICO GRAU III/IV

DOSE:

- 01 BOLSA DE CH → ELEVA HB ≈ 1 G/DL | HT ≈ 3%
- INFUNDIR EM 60 A 120 MIN
- USAR EM ATÉ 6H APÓS ABERTURA
- REAVALIAR HB/HT 1 A 2H APÓS INFUSÃO

2. CONCENTRADO DE PLAQUETAS

INDICAÇÕES PROFILÁTICAS:

- PLAQUETAS < 10.000 (EXCETO PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE - PTI)
- PLAQUETAS < 20.000 + FATORES DE RISCO (SEPSE, ETC.)
- PRÉ-PROCEDIMENTOS INVASIVOS

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS:

- PLAQUETAS < 20.000 + DISTÚRBIOS DE COAGULAÇÃO
- PLAQUETAS < 100.000 EM NEUROCIRURGIA, TCE, POLITRAUMA
- PARTE DO PROTOCOLO DE TRANSFUSÃO MACIÇA

DOSE:

- 01 UNIDADE/10 KG (EX: 06 UNIDADES PARA 60 KG)
- 01 AFÉRESE = 5 A 6 UNIDADES
- ELEVA ≈ 50.000 PLAQUETAS
- INFUNDIR EM 30 MIN | MÁXIMO: 20-30 ML/KG/H

METAS PARA PROCEDIMENTOS:

- CIRURGIA MAIOR: > 80.000
- NEUROCIRURGIA/OFTALMO: > 100.000
- PUNÇÃO LOMBAR: > 50.000

Disponiibilizado Gratuitamente

3. PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)
INDICAÇÕES:

- INR > 1,8 COM SANGRAMENTO
- INR > 2,5 PRÉ-PROCEDIMENTO
- COAGULOPATIA NA TRANSFUSÃO MACIÇA
- INTOXICAÇÃO POR VARFARINA (QUANDO NÃO DISPONÍVEL O COMPLEXO PROTROMBÍNICO)

DOSE:

- 10 A 20 ML/KG (≈ 04 UNIDADES EM ADULTO)
- 01 UNIDADE = 200 A 250 ML
- INFUNDIR EM ATÉ 1H

4. CRIOPRECIPITADO
INDICAÇÕES:

- FIBRINOGÊNIO < 1,5 A 2,0 G/DL COM SANGRAMENTO
- LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA (FASE AGUDA)
- HEMOFILIA A / DOENÇA DE VON WILLEBRAND (SE SEM FATOR CONCENTRADO)

DOSE:

- 01 UNIDADE / 10 KG (EX: 06 UNIDADES PARA 60 KG)
- INFUNDIR IMEDIATAMENTE APÓS DESCONGELAMENTO

5. TRANSFUSÃO MACIÇA
INDICAÇÃO:

- PERDA DE 50% DO VOLUME SANGUÍNEO EM 3H
- USO DE 10 CH EM 24H
- PERDA > 150 ML/MIN POR 20 MIN

PROTOCOLO:

- RELAÇÃO 1:1:1 → CH : PFC : PLAQUETAS

6. HEMOCOMPONENTES MODIFICADOS

- **IRRADIADOS:** IMUNOSSUPRIMIDOS, TRANSPLANTES, TMO

Disponiibilizado Gratuitamente

- **FILTRADOS:** REAÇÃO FEBRIL NÃO HEMOLÍTICA, PREVENÇÃO DE ALOIMUNIZAÇÃO
- **LAVADOS:** ANAFILAXIA PRÉVIA, DEFICIÊNCIA DE IgA

Disponiibilizado Gratuitamente

OUTRAS EMERGÊNCIAS

CHOQUE HIPOVOLÊMICO

RX USO INTRAVENOSO – CRISTALOIDES
1- RINGER LACTATO 1000 ML _____ 01 BOLSA
INFUNDIR 20 A 40 ML/KG NAS PRIMEIRAS HORAS. REPETIR ALÍQUOTAS DE 250–500 ML CONFORME AVALIAÇÃO DE FC, PA E AUSCULTA RESPIRATÓRIA.

2- SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML _____ 01 BOLSA
USAR COMO ALTERNATIVA, MESMO ESQUEMA DO RINGER.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS:
• RINGER LACTATO NÃO CAUSA ACIDOSE HIPERCLORÊMICA, PORÉM DEVE SER EVITADO EM CASOS DE HIPERCALEMIA OU DISFUNÇÃO HEPÁTICA COM RISCO DE ACÚMULO DE LACTATO.
• SF 0,9% PODE CAUSAR ACIDOSE HIPERCLORÊMICA.

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA

– CONDUTA EM CHOQUE CLASSE III OU IV

INDICAÇÃO:
• CHOQUE HIPOVOLÊMICO GRAU III OU IV COM PERDA SANGUÍNEA SIGNIFICATIVA
• HEMOGLOBINA ≤ 7 G/DL

PRESCRIÇÃO:
• ***TRANSFUSÃO CONFORME ESQUEMA:***
1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS : **1** PLASMA FRESCO CONGELADO : **1** CONCENTRADO DE PLAQUETAS
• CADA CONCENTRADO DE HEMÁCIAS AUMENTA EM MÉDIA 1 G/DL NA HEMOGLOBINA
• MANTER HB > 7 G/DL

DROGAS VASOATIVAS – QUANDO NÃO HOUVER RESPOSTA À VOLUME

OPÇÕES DISPONÍVEIS:
1- NORADRENALINA 4 MG/4 ML _____ 02 AMP + 250 ML SG5%
INFUSÃO EM BIC: 0,05 A 2,0 MCG/KG/MIN

Disponiibilizado Gratuitamente

2- VASOPRESSINA 20 UI/ML _____ 01 AMP + 100 ML SF 0,9%
INFUSÃO: 0,01 A 0,04 U/MIN

3- DOBUTAMINA 250 MG/20 ML _____ 01 AMP + 250 ML SG5%
INFUSÃO: 2 A 20 MCG/KG/MIN (USAR EM CASO DE DISFUNÇÃO MIOCÁRDICA ASSOCIADA)

4- DOPAMINA 200 MG/5 ML _____ 01 AMP + 250 ML SG5%
INFUSÃO: 5 A 20 MCG/KG/MIN

OBSERVAÇÃO:
INICIAR DROGAS VASOATIVAS SOMENTE APÓS REPOSIÇÃO VOLÊMICA ADEQUADA. MONITORAR PAM, DÉBITO URINÁRIO E PERFUSÃO TECIDUAL.

CHOQUE ANAFILÁTICO

RX USO INTRAMUSCULAR

1- EPINEFRINA 1 MG/1 ML _____ 01 AMPOLA
APLICAR 0,5 MG (MEIA AMPOLA) IM NA FACE ÂNTERO-LATERAL DA COXA.
PODE REPETIR A DOSE EM ATÉ 2 VEZES, EM INTERVALOS DE 5 A 15 MINUTOS.

SE REFRATÁRIO:

RX USO INTRAVENOSO – INFUSÃO CONTÍNUA
2- EPINEFRINA 1 MG/1 ML _____ 01 AMPOLA
DILUIR 01 AMPOLA EM 100 ML DE SF 0,9%, EV (ACESSO CENTRAL), EM BIC.
DOSE: 0,1 MCG/KG/MIN

RX USO INTRAVENOSO – BOLUS
3- HIDROCORTISONA 100 MG PÓ INJETÁVEL _____ 02 AMPOLAS
RECONSTITUIR E APLICAR EV EM BOLUS LENTO

4- DIFENIDRAMINA 50 MG/ML _____ 01 AMPOLA
APLICAR 01 AMPOLA EV EM BOLUS LENTO (MÁXIMO 400 MG/DIA)

RX USO INTRAMUSCULAR

5- PROMETAZINA 50 MG/2 ML _____ 01 AMPOLA
APLICAR 01 AMPOLA (50 MG) IM

Disponiibilizado Gratuitamente

REPOSIÇÃO VOLÊMICA (SE HIPOTENSÃO):
6- SF 0,9% OU RINGER LACTATO _____ 1000 ML
INFUNDIR 20 A 40 ML/KG NAS PRIMEIRAS HORAS + REPETIR ALÍQUOTAS DE 250 A 500 ML, CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA

SE CHOQUE REFRATÁRIO:

RX USO INTRAVENOSO – INFUSÃO CONTÍNUA
7- NORADRENALINA 4 MG/4 ML _____ 02 AMPOLAS
DILUIR 02 AMPOLAS EM 250 ML DE SG 5%, EV EM BIC
DOSE: 0,05 A 2,0 MCG/KG/MIN

INTOXICAÇÃO EXÓGENA

LAVAGEM GÁSTRICA COM SF 0,9% 500ML POR MEIO DE SNG DE GROSSO CALIBRE;

CARVÃO ATIVADO 50G + SF 0,9% 200ML POR SNG, APÓS LAVAGEM GÁSTRICA;

CARVÃO ATIVADO 25G + SF 0,9% 100ML POR SNG DE 6/6H

ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

SOLICITAR ANTI-HIV, HBSAG, HCV, ANTI- HBC (IGM E IGG), ANTI-HBS TITULADO; VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B, CASO NÃO TENHA;

ESQUEMA ANTIRRETROVIRAL (INICIAR ATÉ 72H PÓS EXPOSIÇÃO):

• TENOFOVIR + LAMIVUDINA [300 MG + 300 MG/CP] _____ TOMAR 01 CP, VO, 24/24H, POR 28 DIAS; +

• DOLUTEGRAVIR 50 MG _____ TOMAR 1CP, VO, 24/24H, POR 28 DIAS.

RAIVA

1) SORO ANTIRRÁBICO – 5 ML NO LOCAL DA FERIDA + 5 ML ,IM, NO GLÚTEO

2) VACINA ANTIRRÁBICA – 01 AMP IM.

Disponiibilizado Gratuitamente